



Nuansa
Fajar
Cemerlang

BULLYING DI SEKOLAH DAN RESIKO BUNUH DIRI PADA REMAJA



Yuldensia Avelina
Wihelmus Nong Baba

BULLYING DI SEKOLAH DAN RESIKO BUNUH DIRI PADA REMAJA

Penulis:

Yuldensia Avelina, S.Kep., Ns., M.Kep.
Wihelmus Nong Baba, S.Kep., Ns., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bullying di Sekolah dan Resiko Bunuh Diri Pada Remaja

Penulis: Yuldensia Avelina, S.Kep., Ns., M.Kep.

Wihelmus Nong Baba, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-97-2

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Penulis mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmatNya, penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah memberikan kontribusi terhadap penulisan buku ini.

Buku monograf **"bullying di sekolah dan resiko bunuh diri pada remaja"** lahir karena kepedulian penulis terhadap masalah bullying yang terus menerus terjadi dalam dunia pendidikan dan lebih besar mengenai kelompok usia remaja. Pada umumnya bullying memberikan dampak negatif baik kepada pelaku, korban, dan saksi. Oleh karena itu, buku ini mengulas tentang bullying di sekolah, bunuh diri remaja, dan evidence-based practice.

Keunggulan buku monograf **"bullying di sekolah dan resiko bunuh diri pada remaja"**, buku ini membahas tentang konsep dan aplikasi tentang bullying di sekolah dan pengaruhnya terhadap resiko bunuh diri remaja. Konsep dan aplikasi melalui evidence based-practice membantu pembaca memahami tentang bullying di sekolah dan dampak negatifnya terhadap semua pihak yang terlibat dalam perilaku bullying serta dapat melakukan intervensi yang tepat untuk mengurangi bahkan menghilangkan bullying di sekolah. Dengan demikian, dapat menekan kejadian resiko bunuh diri.

Penulis mengharapkan agar buku ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesehatan jiwa remaja dan meningkatkan suasana pendidikan yang anti-bullying.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 BULLYING DI SEKOLAH	7
A. Pengertian Bullying di Sekolah.....	7
B. Faktor Resiko Bullying di Sekolah.....	8
C. Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying.....	18
D. Dampak Perilaku Bullying.....	19
E. Program Anti-Bullying di Sekolah	20

BAB 3 BUNUH DIRI PADA REMAJA	25
A. Pengertian Bunuh Diri.....	25
B. Faktor Risiko Bunuh Diri Pada Remaja.....	25
C. Deteksi Dini Resiko Bunuh Diri dan Asesmen Khusus Resiko Bunuh Diri	31
D. Tanda dan Gejala Bunuh Diri.....	34
E. Monitoring, Klasifikasi, dan Pertolongan Pertama (First Aid) Resiko Bunuh Diri	35
F. Dampak Bunuh Diri.....	41

BAB 4 EVIDANCED BASED PRACTICE.....	45
A. Pengertian Evidence-Based Practice	45
B. Tujuan dan Manfaat Evidence-Based Practice.....	45
C. Evidence-Based Practice Bullying dengan Resiko Bunuh Diri Remaja.....	46

D. Evidence-Based Practice Intervensi Bullying di Sekolah	50
---	----

BAB 5 PENUTUP	57
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	69
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	73
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Bullying masih menjadi masalah kesehatan masyarakat utama yang memengaruhi masalah kesehatan mental pada anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Bullying juga masih menjadi perhatian di dunia pendidikan saat ini. Bullying didefinisikan sebagai tindakan menyakiti atau mempermalukan seseorang yang kekuatannya lebih rendah daripada penyerang. Bullying dapat mencakup serangan fisik (misalnya, mendorong), pelecehan verbal (misalnya, mencaci maki), menyebarkan rumor, gerakan cabul, dan pengucilan sosial. Bullying telah dikaitkan dengan masalah kesehatan fisik dan mental seperti kecemasan dan depresi, peningkatan resiko melukai diri sendiri, percobaan atau bunuh diri, kinerja akademis yang buruk, serta kriminalitas dan kenakalan (Francis et al., 2022).

Data meta-analisis dari 80 studi internasional terhadap remaja berusia 12–18 tahun melaporkan tingkat prevalensi bullying rata-rata sebesar 35% untuk keterlibatan dalam bullying secara langsung dan 15% untuk cyberbullying (Francis et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2018 dengan mengambil data dari seluruh dunia diperoleh bahwa sepertiga dari anak-anak dan remaja di seluruh dunia menjadi korban bullying (O'Higgins Norman, 2020). Studi lain mengungkapkan bahwa bullying tersebar luas di negara-negara Asia Tenggara, dengan tingkat prevalensi 1% hingga 7,7% (Ahmed et al., 2022).

Kasus bullying di beberapa negara mengalami peningkatan prevalensi mulai dari negara-negara di Timur Tengah diikuti negara Amerika Serikat kemudian negara-negara di Eropa, Karibia, dan Asia. Kasus cyberbullying di Irlandia pada tahun 2017 ditemukan bahwa 26% anak sekolah dasar dan 12% anak sekolah pasca-dasar telah dibully secara luring, dengan 14% anak sekolah dasar dan 10% anak sekolah pasca-dasar dibully secara daring. Pada tahun 2019, di Irlandia ditemukan bahwa 57% anak berusia 15–18 tahun diminta untuk membagikan gambar seksual, 24% membagikan gambar seksual, dan 13% gambar seksual dibagikan tanpa persetujuan mereka. Jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat sebesar 28%, dengan 478 kasus di antaranya diselidiki dan ditemukan serius. Bullying di Jepang bisa lebih ekstrim secara fisik dan menyebabkan anak laki-laki dan perempuan mempertimbangkan bunuh diri sebagai cara melarikan diri dari rasa sakit fisik (O'Higgins Norman, 2020).

Kasus bullying di Indonesia berdasarkan data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan perincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus,

korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak (Novianto et al., 2024).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun hingga September 2024 tercatat ada 293 kasus kekerasan di sekolah. Jenis kekerasan didominasi oleh kekerasan seksual, jumlahnya mencapai 42%. Disusul oleh bullying 31%, kekerasan fisik 10%, kekerasan psikis 11%, dan kebijakan yang mengandung kekerasan 6%. Dalam kasus kekerasan seksual, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 78%. Sementara korban laki-laki hanya 22%. Namun, jika dilihat dari sisi pelaku, laki-laki sangat dominan yaitu 89% sedangkan perempuan 11%. Apabila dilihat dari jumlahnya, terjadi peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya. Bahkan, jumlah kasus di tahun 2024 sudah melebihi total kasus di 2023 yakni sebanyak 285 kasus (Sania Mashabi, 2024).

Tingkat keparahan dampak bullying yang dirasakan oleh siswa yang menjadi korban berbeda-beda tergantung jenis bullying yang diterima, frekuensi di bully, dan ketahanan siswa tersebut terhadap stres. Dimana ada siswa yang langsung melaporkan kejadian bullying yang diterimanya kepada guru, namun ada yang memilih diam karena takut. Gejala klinis sebagai dampak perilaku bullying kadang tidak terdeteksi oleh guru (Rigby, 2020). Dampak negatif secara psikologis yang dialami oleh korban bullying

adalah stres, depresi, gejala psikotik hingga melakukan bunuh diri (Rigby, 2020).

Perilaku menyakiti diri sendiri yang disengaja, atau perilaku bunuh diri, adalah salah satu penyebab utama kematian di kalangan remaja. Pada tahun 2019, bunuh diri menjadi penyebab kematian nomor satu di kalangan remaja berusia 10-19 tahun di Korea Selatan. Sekitar 30% remaja dengan pikiran bunuh diri benar-benar mencoba bunuh diri. Di Korea, selama periode 12 bulan, 12,2% remaja secara serius mempertimbangkan bunuh diri dan 2,4% benar-benar mencoba bunuh diri. Studi lain terhadap remaja Korea melaporkan bahwa 8,3% remaja telah mempertimbangkan bunuh diri secara serius dan 3,2% telah mencoba bunuh diri dalam 12 bulan terakhir. Namun, percobaan bunuh diri terjadi sekitar 10-20 kali lebih sering daripada bunuh diri yang sebenarnya (Kwon et al., 2022).

Upaya penanganan bullying di sekolah melibatkan guru dan konselor (psikolog) dengan metode yang digunakan yaitu mengidentifikasi kasus bullying di sekolah, memanggil semua siswa yang terlibat dalam perilaku bullying baik korban, saksi, dan pelaku. Amerika Serikat, psikolog pendidikan memberikan perkiraan tindakan yang diambil oleh guru untuk menangani kasus bullying. Tindakan yang dianggap paling umum (disetujui oleh lebih dari 90% psikolog pendidikan) adalah berbicara dengan pelaku bullying; mengambil tindakan disiplin; meningkatkan pengawasan di area tersebut; berbicara dengan korban; menasihati pelaku bullying; dan menasihati korban. Di Inggris, survei terhadap 1378 sekolah dilakukan untuk memastikan tindakan apa yang mereka lakukan dalam kasus bullying. Dalam studi di Inggris, metode intervensi khusus ditetapkan. Lebih dari 90% sekolah melaporkan bahwa

mereka terkadang menggunakan sanksi langsung, seperti teguran, penahanan, dan skorsing, tetapi yang lebih umum adalah strategi utama mereka menggunakan praktik restoratif, dengan metode non-konfrontasi seperti Metode Kelompok Dukungan dan Metode Kepedulian Bersama atau Metode Pikas yang hanya digunakan dalam sebagian kecil kasus (O'Higgins Norman, 2020; Rigby, 2020).

Upaya mencegah dan menangani kekerasan pada anak di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) telah memberlakukan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Permendikbud PPKSP tersebut dimaksudkan untuk memperkuat tindak pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dengan memperluas lingkup sasaran ke peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memastikan bahwa warga satuan pendidikan aman dari berbagai jenis kekerasan. Jika Permendikbudristek tersebut dikaji, setidaknya ada tiga ranah pencegahan dan penanganan yang perlu dilakukan, yakni pada ranah tata kelola, edukasi, dan sarana-prasarana. Pada tiga ranah tersebut, ada peran satuan pendidikan dan peran pemerintah daerah (Sania Mashabi, 2024).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mencari hubungan bullying dengan masalah psikologis pada remaja di sekolah yakni yang dilakukan oleh Yanzami et al. (2020); Yosep, Iyus et al, (2024); Syamsul et al. (2024); Yanzami & Widyastuti (2021). Namun memiliki perbedaan dimana sasarannya pada remaja SMA/SMK dan berkaitan dengan

pandemic covid 19. Penelitian tersebut belum menyasar siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SLTP) (Yanzami, 2021; Yosep et al., 2024).

BAB 2

BULLYING DI SEKOLAH

A. Pengertian Bullying di Sekolah

Bullying adalah bentuk perilaku agresif tertentu yang dilakukan secara sistematis, terarah, berulang kali dalam jangka waktu yang lama dengan tujuan untuk menyakiti korban yang secara fisik dan sosial lebih lemah dari pelaku (Danelien A. E. van Aalst; Gijs Huitsing & René Veenstra, 2024; Saskia M. Fischer, 2021). Bullying juga didefinisikan sebagai perilaku agresif yang mengandung tiga elemen yaitu niat untuk menyakiti, sifatnya berulang dan ketidakseimbangan kekuatan yang jelas antara pelaku dan korban (Hannah Gaffney, Maria M. Ttofi, 2021).

Bullying di sekolah merupakan salah satu bentuk bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah antara individu yang biasanya berusia 4-18 tahun. Bullying di sekolah merupakan bentuk fenomena sosial yang kompleks, seringkali terjadi antara pelaku dan korban secara terpisah, misalnya individu dapat terlibat dalam bullying tidak hanya sebagai pelaku dan korban bullying melainkan juga sebagai saksi, pembela, atau penguat. Bullying di sekolah sering terjadi dan guru sering sulit untuk mendeteksi kejadian bullying di sekolah (Danelien A. E. van Aalst; Gijs Huitsing & René Veenstra, 2024; Hannah Gaffney, Maria M. Ttofi, 2021).

B. Faktor Resiko Bullying di Sekolah

Faktor resiko terjadinya bullying di sekolah disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor individual

- a. Jenis kelamin (gender)
Pelaku bullying sebagian besar adalah laki-laki dan menjadi korban sebagian besar pada perempuan. Namun, beberapa kasus pelaku bisa terjadi pada perempuan dan korban bisa terjadi pada laki-laki (Ahmed et al., 2022; Johansson, 2023).
- b. Usia
Kejadian bullying lebih sering terjadi pada usia 14 sampai dengan 18 tahun (Farrington, 2020).
- c. Tingkatan kelas
Bullying paling umum terjadi di sekolah menengah pertama, tetapi penelitian menunjukkan bahwa bullying paling tinggi terjadi di sekolah saat siswa bersiap memasuki sekolah menengah atas (yaitu antara sekolah dasar dan menengah pertama serta sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas) (Ahmed et al., 2022).
- d. Suku bangsa
Keterlibatan dalam bullying merupakan fenomena antarbudaya dan etnis. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa siswa sekolah yang berasal dari kelompok etnis minoritas lebih mungkin mengalami pelecehan daripada kelompok etnis mayoritas (Ahmed et al., 2022).
- e. Status sosial ekonomi
Peningkatan kesenjangan status sosial ekonomi diantara siswa berpotensi tinggi terjadinya bullying. Siswa dengan status sosial ekonomi tinggi lebih

cenderung menjadi pelaku bullying karena merasa berkuasa dan kurang memiliki empati sedangkan siswa dengan status sosial ekonomi rendah menjadi korban bullying (Ahmed et al., 2022; Farrington, 2020).

f. Karakteristik fisik

1) Berat badan

Siswa dengan berat badan berlebih dapat menjadi pelaku dan juga dapat menjadi korban bullying. Siswa dengan kelebihan berat badan ketika menjadi pelaku karena merasa bahwa ia menjadi sosok terkuat dan tak terkalahkan sehingga dapat menindas yang lain. Namun, ketika menjadi korban karena adanya penolakan dari teman sebaya terkait penampilan fisik. Selain siswa dengan kelebihan berat badan, siswa dengan kondisi tubuh kurus cenderung menjadi korban bullying (Ahmed et al., 2022; Johansson, 2023).

2) Keterampilan motorik

Siswa dengan keterampilan motorik lemah cenderung menjadi korban bullying di sekolah (Johansson, 2023).

g. Perilaku eksternalisasi

Menjadi seorang pelaku biasanya dikaitkan dengan perilaku eksternalisasi (misalnya, agresif, menantang, mengganggu, atau nakal), sedangkan menjadi korban dikaitkan dengan perilaku internalisasi (misalnya, kecemasan, depresi, atau harga diri yang rendah) (Ahmed et al., 2022). Impulsivitas dan hiperaktivitas meningkatkan kemungkinan terjadinya bullying dan merupakan faktor eksternal. Dimana para pelaku bullying melakukannya sebagai upaya pencarian sensasi. Pencarian sensasi juga telah diidentifikasi

sebagai prediktor terjadinya bullying (Johansson, 2023).

Agresivitas berhubungan dengan perilaku bullying. Agresi proaktif yang berhubungan dengan kekuasaan (agresivitas untuk meningkatkan kekuasaan seseorang dalam kelompok, mengintimidasi orang lain), dan agresi proaktif yang berhubungan dengan afiliasi (agresivitas untuk mendapatkan persahabatan, penerimaan kelompok) merupakan prediktor untuk melakukan bullying. Agresivitas juga berhubungan dengan penolakan teman sebaya karena pelaku bullying cenderung melihat lebih banyak konflik dan hubungan yang lebih buruk dengan teman sebaya (Johansson, 2023).

h. Harga diri

Harga diri yang rendah termasuk wawasan negatif yang berhubungan dengan diri sendiri (yang lemah) berdampak menjadi korban bullying. Sedangkan narsisme, kesombongan, dan sifat emosional yang tidak berperasaan (seperti kurangnya empati dan rasa malu) lebih erat kaitannya sebagai pelaku bullying (Ahmed et al., 2022).

i. Popularitas dan keterampilan sosial

"Masalah hubungan sosial" telah digunakan untuk menggambarkan bullying. Pelaku dan korban bullying memiliki kekurangan keterampilan sosial. Meskipun banyak teman sekelas tidak selalu menyukai mereka secara pribadi, pelaku bullying dapat dilihat di antara teman-teman mereka sebagai orang yang populer, berpengaruh, dan "keren". Selain itu, anggota pelaku bullying sering kali menjadi pusat perhatian dan memiliki teman-teman di jaringan teman sebaya

mereka. Seperti orang lain yang terlibat dalam dan berafiliasi dengan perilaku serupa, remaja dapat memperkuat perilaku koersif orang lain (Ahmed et al., 2022).

Korban bullying menunjukkan kurang memiliki keterampilan sosial yang memadai, memiliki sikap dan keyakinan yang berhubungan dengan diri sendiri yang negatif, mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah sosial, tidak memiliki keterampilan pemecahan masalah sosial yang memadai. Pelaku bullying lebih kompeten secara sosial daripada korban. Namun, korban bullying memiliki tantangan paling berat dalam kompetensi sosial dari semua kelompok (Johansson, 2023).

Tingkat keterampilan sosial (kompetensi) yang lebih rendah dapat mengakibatkan tantangan dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang memuaskan, yang pada gilirannya dapat diartikan sebagai ekspresi bahwa korban mengalami maladjustment sosial. Masalah internalisasi, dalam bentuk ketidakberdayaan, rasa tidak aman, perasaan rendah diri, suasana hati yang buruk, kegelisahan, insomnia, dan gejala depresi berkorelasi negatif dengan pelaku bullying, dan berkorelasi positif dengan korban bullying. Di samping masalah internalisasi ini, kurangnya empati lebih mungkin terjadi di antara para pelaku bullying, dan kecemasan serta ide bunuh diri lebih mungkin terjadi di antara para korban (Johansson, 2023).

j. Prestasi akademis

Perilaku bullying oleh teman sebaya dikaitkan dengan prestasi yang lebih rendah, terutama jika siswa yang

diejek tidak masuk sekolah dan kehilangan kesempatan pendidikan (Ahmed et al., 2022; Johansson, 2023).

k. Disabilitas fisik

Siswa dengan gangguan perilaku lebih mungkin mengalami bullying, tetapi bullying bisa jadi merupakan bentuk pembalasan terhadap bullying.

l. Pengendalian diri

Pengendalian diri merupakan karakteristik intrapersonal yang memengaruhi keterlibatan dalam bullying. Menurut teori pengendalian diri, anak-anak dan remaja dengan tingkat pengendalian diri yang lebih rendah cenderung tidak terlibat dalam perilaku yang diinginkan secara sosial. Mengingat keadaan tertentu, individu-individu ini cenderung terlibat dalam perilaku berisiko dan kriminal karena kecenderungan mereka yang lebih besar untuk bersikap impulsif, egois, dan picik. Selain itu, individu-individu ini cenderung tidak takut akan potensi konsekuensi buruk dari perilaku kekerasan, yang berkontribusi pada peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas berisiko (Xue et al., 2022).

2. Faktor teman sebaya

a. Norma kelompok sebaya

Jika anggota kelompok sebaya terlibat dalam bullying, yang lain akan mengalaminya. Selain itu, siswa yang menjadi pelaku bullying lebih mungkin berasal dari kelompok sebaya yang signifikan secara sosial (Ahmed et al., 2022).

Hubungan dengan teman sebaya yang antisosial (berteman dengan pelaku bullying atau berteman dengan orang yang memiliki sikap bullying)

merupakan faktor resiko terjadinya bullying, karena meningkatkan kemungkinan menjadi pelaku bullying (Johansson, 2023).

b. Sikap permisif

Remaja dengan sikap permisif terhadap bullying lebih mungkin menjadi pelaku bullying.

Siswa yang berhasil melakukan perilaku bullying tanpa dihukum atau bahkan diberi penghargaan berupa peningkatan status sosial atau dominasi, dapat mendukung dan mereproduksi sikap permisif terhadap bullying dan melawan sikap anti-bullying di antara teman sekelasnya. sikap permisif atau mendukung teman sekelasnya terhadap bullying dan frekuensi perilaku bullying di kelas mereka merupakan faktor risiko bagi siswa untuk menjadi pelaku bullying (Johansson, 2023).

c. Kenakalan dan perilaku antisosial

Pengaruh teman sebaya merupakan prediktor signifikan terhadap partisipasi dalam pelecehan. Pengaruh teman sebaya yang negative dikaitkan dengan bullying dan menjadi korban. Selain itu, kenakalan (misalnya, vandalisme, keanggotaan dalam geng, dan membawa senjata ke sekolah) berkorelasi dengan tingkat bullying yang lebih tinggi (Ahmed et al., 2022).

Perilaku antisosial seperti terlibat dalam perkelahian fisik, mengangkat senjata, konsumsi tembakau, alkohol, atau obat-obatan terlarang dalam jumlah besar, dan masalah perilaku, seperti teguran dan pengusiran dari sekolah, juga telah diidentifikasi sebagai faktor risiko perilaku bullying (Johansson, 2023).

d. Penggunaan alkohol dan narkoba

Bullying dan penyalahgunaan alkohol/narkoba diketahui saling terkait. Misalnya, sebuah studi terhadap orang dewasa di Amerika Serikat menemukan bahwa bullying secara signifikan berhubungan dengan penggunaan alkohol dan narkoba seumur hidup. Dengan demikian, keterlibatan dalam bullying dikaitkan dengan penggunaan alkohol/narkoba secara bersamaan dan di masa mendatang (Ahmed et al., 2022).

3. Faktor sekolah

a. Iklim sekolah

Iklim sekolah juga telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor resiko untuk menjadi korban dan pelaku bullying. iklim sekolah yang negatif dan komitmen sekolah yang rendah maka dapat meningkatkan kasus terjadinya bullying (Ahmed et al., 2022; Hannah Gaffney, Maria M. Ttofi, 2021).

Iklim sekolah yang negatif dan komitmen sekolah yang rendah dapat ditunjukkan dari tidak adanya norma anti bullying; tidak ada aturan yang jelas, konsisten dan adil terhadap korban bullying atau pro korban; tidak ada intervensi yang tegas terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bullying; dukungan guru yang rendah terhadap adanya norma anti-bullying di sekolah; manajemen kelas yang buruk seperti tidak menciptakan suasana kelas yang positif dan toleran terhadap emosi masing-masing siswa (Johansson, 2023).

b. Sikap guru

Peran guru sangat penting dalam melawan bullying di kelas. Respon guru terhadap bullying akan bervariasi tergantung pada keyakinan dan sikap masing-masing. Beberapa guru menganggap bullying sebagai perilaku normal yang dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan percaya bahwa tidak perlu campur tangan, karena mereka tidak bersimpati dengan korban. Lebih jauh, guru tidak akan ikut campur dalam mengatasi bullying ketika mereka melihat bahwa perilaku tersebut bukan bullying atau ketika ada kejadian lain dalam bentuk-bentuk tersembunyi seperti bullying relasional atau verbal atau ketika guru tidak melihat perilaku tersebut sebagai bullying (Ahmed et al., 2022).

c. Karakteristik kelas

Sekolah merupakan gabungan dari banyak kelas dan ada insentif untuk mengurangi bullying di lingkungan kelas. Sebuah penelitian mengidentifikasi empat karakteristik utama yang memprediksi terjadinya bullying di kelas: (1) hubungan negatif dengan teman sebaya, (2) hubungan guru-siswa yang buruk, (3) kurangnya pengendalian diri, dan (4) kemampuan memecahkan masalah yang buruk di antara siswa (Ahmed et al., 2022).

d. Rasa memiliki sekolah

Siswa yang menindas siswa lain di sekolah memiliki dasar tingkat afiliasi sekolah yang lebih rendah daripada siswa yang pernah atau tidak pernah menjadi korban bullying (Ahmed et al., 2022).

4. Faktor keluarga

a. Pola asuh

Perilaku pengasuhan anak yang negatif, termasuk pelecehan dan pengabaian serta pengasuhan anak yang maladaptif, terkait dengan peningkatan risiko sedang untuk menjadi pelaku bullying/korban. Pola asuh yang otoriter berhubungan dengan faktor risiko kejadian bullying (Johansson, 2023).

Kemarahan orang tua terhadap anak dan kurang komunikasi antara orang tua dan anak; persepsi orang tua yang negatif terhadap anak (anak mengganggu mereka, sering membuat mereka marah, sulit dirawat) dan kesehatan mental ibu yang kurang optimal diidentifikasi sebagai faktor risiko untuk pelaku bullying. Bagi korban atau pelaku bullying/korban, persepsi orang tua mereka sebagai orang yang kurang penyayang, kurang terlibat, dan kurang bertanggung jawab merupakan ciri khas (Johansson, 2023).

Ibu dari korban laki-laki terlalu protektif, suka mengontrol, membatasi, memanjakan, terlalu terlibat, dan hangat, sedangkan ayah mereka menyendiri, kritis, tidak ada, acuh tak acuh, lalai, dan mendominasi. Di sisi lain, korban perempuan memiliki ibu yang bermusuhan yang menolak atau tidak mau memberikan kasih sayang, mengancam dan mendominasi mereka, dan ayah yang ceroboh dan tidak peduli (Ahmed et al., 2022).

b. Konflik keluarga

Seorang anak dengan adanya konflik orang tua di mana orang tua bertengkar, minum minuman keras, menggunakan narkoba, dan melakukan kekerasan fisik atau seksual, serta masalah perselingkuhan dan

perceraian orang tua dapat menyebabkan anak-anak mengalami bullying dan menjadi korban bullying serta dapat juga menjadi pelaku. Kurangnya bimbingan orang tua dan konflik di rumah merupakan tema umum di antara para pelaku bullying. Konflik antara orang tua dan anak-anak mereka merupakan faktor penting lainnya yang berkontribusi terhadap keterlibatan remaja dalam bullying. Teori ketegangan umum menyatakan bahwa ketegangan merupakan faktor penting yang mengakibatkan perilaku berisiko; individu yang mengalami stres cenderung terlibat dalam aktivitas berisiko sebagai strategi penanggulangan untuk menanggapi ketidakadilan (Ahmed et al., 2022; Johansson, 2023; Xue et al., 2022). Penetapan aturan keluarga yang kurang dan minat orang tua yang kurang terhadap pekerjaan sekolah anak-anak mereka, dukungan emosional orang tua, persahabatan, dan aktivitas sebagai faktor risiko terjadinya penindasan, dan dukungan emosional orang tua yang langka, lingkungan rumah yang kasar, keras, atau tidak mendukung, termasuk konflik keluarga dan kekerasan antar orang tua/keluarga, serta sikap dan nilai negatif yang ditularkan sebagai faktor risiko terjadinya penindasan, serta menjadi korban penindasan (Johansson, 2023).

5. Faktor komunitas (lingkungan sekitar)

Karakteristik lingkungan sekitar memiliki dampak signifikan terhadap perilaku bullying. Misalnya, bullying berkembang pesat di lingkungan sekitar yang tidak aman, agresif, dan tidak teratur. Sebaliknya, tinggal di lingkungan sekitar yang aman dan terhubung dikaitkan

dengan tingkat bullying dan viktimisasi yang lebih rendah (Ahmed et al., 2022)(Ahmed et al., 2022).

6. Faktor sosial (media sosial)

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa anak-anak cenderung mempelajari perilaku mereka berdasarkan pengamatan. Selain mengamati orang tua yang membentuk perilaku anak-anak dan remaja melalui platform media sosial.

Paparan terhadap video game, televisi, dan film yang mengandung kekerasan terkait dengan tingkat agresi yang lebih tinggi (Ahmed et al., 2022; Xue et al., 2022).

C. Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying

Coloroso (2020) dan Ahmed, et al. (2022), mengelompokkan bullying menjadi empat jenis yaitu bullying secara verbal, bullying fisik, bullying secara relasional (pengabaian), bullying psikologis, bullying seksual, dan bullying elektronik.

1. Bullying secara verbal

Bullying secara verbal berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi maupun rasial), pernyataan-pernyataan tentang ajakan seksual atau pelcehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip, dan lain-lain.

2. Bullying secara fisik

Bullying secara fisik seperti memukuli, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas.

3. Bullying secara relasional (pengabaian)

Bullying secara relasional adalah pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Perilaku ini mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa yang mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.

4. Bullying secara elektronik

Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, website, *chatting room*, email, SMS, dan sebagainya (Coloroso, 2020).

5. Bullying psikologis

Bullying psikologis seperti pelecehan, intimidasi, dan penghinaan (Ahmed et al., 2022).

6. Bullying seksual

Bullying seksual seperti ancaman atau sentuhan seksual, penggunaan kata-kata kotor, atau tindakan meraba-raba (Ahmed et al., 2022).

D. Dampak Perilaku Bullying

Perilaku bullying memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental baik kepada pelaku bullying maupun korban bullying.

1. Dampak bullying terhadap korban

Korban bullying dapat mengalami gangguan kesehatan mental seperti meningkatnya keinginan untuk bunuh diri, kecemasan umum atau sosial, harga diri rendah dan kesepian, gejala psikotik, depresi, gangguan tidur, gejala psikosomatis lainnya, menurunnya prestasi

akademik, menjauh dari lingkungan sosial dalam menganalisa hal tertentu (Alwi et al., 2023; Hannah Gaffney, Maria M. Ttofi, 2021; Medicine, 2019).

2. Dampak bullying terhadap pelaku

Seseorang yang melakukan tindakan bullying akan merasa percaya diri tinggi. Mereka cenderung agresif, memiliki rasa toleransi rendah, dan tidak berempati terhadap korbannya. Jika pelaku ini tidak ditindaklanjuti maka akan menimbulkan kekerasan lainnya. Pelaku juga dapat mengalami masalah psikotik di kemudian hari dan diisolasi dalam pergaulan teman sebayanya (Coloroso, 2020; Medicine, 2019).

3. Dampak bullying terhadap saksi

Masalah psikologis yang muncul dari para saksi perilaku bullying adalah perasaan cemas dan tidak aman, yang sebagian berasal dari ketakutan akan pembalasan dan yang sering kali menghalangi para saksi untuk mencari bantuan (Medicine, 2019).

Menyaksikan bullying secara signifikan dapat meningkatkan risiko kesehatan mental bahkan setelah mengendalikan dampak menjadi pelaku atau korban seperti para saksi dapat terjerumus dalam penggunaan obat-obatan dan lebih banyak gejala kepekaan interpersonal (misalnya, perasaan terluka atau rendah diri), ketidakberdayaan, dan potensi ide bunuh diri (Medicine, 2019).

E. Program Anti-Bullying di Sekolah

Program anti-bullying di Indonesia telah dilakukan di beberapa sekolah di Indonesia. Program anti-bullying pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia melalui Program ROOTS (UNICEF, 2017).

Program ROOTS yang dikembangkan oleh UNICEF yang ditujukan pada siswa SMP. Kegiatan ROOTS berlangsung di sekolah, dimana siswa akan membuat berbagai tanda/materi cetak pencegahan kekerasan di sekolah, foto, menyelenggarakan kegiatan festival atau kampanye satu hari yang akan diramalkan oleh berbagai aktivitas yang didesain oleh siswa, kartu perilaku positif (dimana siswa akan mempraktikkan perilaku positif tersebut dan memberi tanda setiap mempraktikkannya), gelang untuk menyebarkan pesan (dimana siswa akan membagikannya setiap melihat rekannya mempraktikkan perilaku positif yang telah mereka sebarkan di sekolah), poster, baju, petisi untuk ditandatangani, kotak perubahan, dan sebagainya (UNICEF, 2017).

ROOTS memiliki jumlah pertemuan sebanyak 15 kali atau sesi. Berikut akan ditampilkan sesi, materi, dan *soft skill* yang dikembangkan:

Tabel 2.1 Daftar Pertemuan ROOTS

Sesi	Materi	<i>Soft Skill</i> yang Dikembangkan
Sesi 1	Pengenalan program.	1. Bekerja sama; 2. Pertemanan dan hubungan sosial/<i>relationship</i>.
Sesi 2	Meningkatkan rasa percaya dalam kelompok sebaya.	1. Pertemanan dan hubungan sosial/<i>relationship</i>; 2. Penghargaan terhadap keberagaman; 3. Mengenal/mengelola diri sendiri dan partisipasi.

Sesi	Materi	<i>Soft Skill</i> yang Dikembangkan
Sesi 3	Mengenal <i>bullying</i>	1. Pertemanan dan hubungan sosial/<i>relationship</i>; 2. Menolak tekanan sebaya; 3. Anti kekerasan dan bullying.
Sesi 4	Kepemimpinan dan komunikasi efektif.	1. Berkomunikasi efektif; 2. Pengambilan keputusan; 3. Mengenal/mengelola diri sendiri.
Sesi 5	Melihat dari perspektif yang berbeda dan membangun hubungan yang sehat.	1. Empati; 2. Pertemanan dan hubungan sosial/<i>relationship</i>; 3. Kesehatan menstrual; 4. Pubertas.
Sesi 6	Memberikan respon terhadap konflik.	1. Menolak tekanan sebaya; 2. Mengelola resiko.
Sesi 7	Membuat perubahan perilaku secara positif.	1. Merencanakan atau mengorganisir; 2. Menolak tekanan sebaya; 3. Pertemanan dan hubungan sosial/<i>relationship</i>.
Sesi 8	Mengembangkan rekomendasi kebijakan sekolah pencegahan kekerasan.	1. Partisipasi; 2. Berkomunikasi efektif.

Sesi	Materi	<i>Soft Skill</i> yang Dikembangkan
Sesi 9	Mengembangkan dan mempraktikkan permainan peran (<i>role play</i>) berdasarkan observasi siswa terhadap perilaku bullying di sekolah.	1. Berpikir kritis; 2. Pertemanan dan hubungan sosial/<i>relationship</i>; 3. Menolak tekanan teman sebaya; 4. Anti kekerasan dan bullying.
Sesi 10	Membuat aksi yang melibatkan seluruh siswa.	1. Berpikir kritis; 2. Pertemanan dan hubungan sosial/<i>relationship</i>; 3. Menolak tekanan teman sebaya; 4. Anti kekerasan dan bullying; 5. Merencanakan atau mengorganisir.
Sesi 11	Merancang aktivitas ROOTS di sekolah.	1. Partisipasi; 2. Anti kekerasan dan bullying; 3. Merencanakan atau mengorganisir.
Sesi 12	Menyusun dan memperkuat pesan (melalui <i>hashtag</i>).	1. Berkomunikasi efektif; 2. Partisipasi; 3. Anti kekerasan dan bullying; 4. Merencanakan atau mengorganisir; 5. Kreativitas.
Sesi 13	Persiapan aktivitas ROOTS di sekolah.	1. Berkomunikasi efektif; 2. Partisipasi;

Sesi	Materi	<i>Soft Skill yang Dikembangkan</i>
		3. Anti kekerasan dan bullying; 4. Merencanakan atau mengorganisir; 5. Kreativitas.
Sesi 14	Pelaksanaan aktivitas ROOTS di sekolah.	1. Partisipasi; 2. Anti kekerasan dan bullying; 3. Merencanakan atau mengorganisir; 4. Kreativitas.
Sesi 15	Evaluasi terhadap program ROOTS	1. Partisipasi; 2. Merencanakan atau mengorganisir; 3. Kreativitas.

Sumber (UNICEF, 2017)

BAB 3

BUNUH DIRI PADA REMAJA

A. Pengertian Bunuh Diri

Bunuh diri merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di banyak negara terutama pada kelompok anak-anak, remaja, dan usia paruh baya. Pada tahun 2012, WHO mengungkapkan bunuh diri merupakan penyebab kematian nomor dua terbanyak pada kelompok usia 15-29 tahun (Rizkia, 2023).

Kata bunuh diri berasal dari Bahasa Latin dari kata "*Suicaedere*", *sui* berarti diri dan *caedere* berarti membunuh. Jadi, bunuh diri adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya (Avelina, 2023).

Bunuh diri menurut Miller (2002) adalah usaha tindakan atau pikiran yang bertujuan untuk mengakhiri hidup yang dilakukan dengan sengaja, mulai dari pikiran pasif tentang bunuh diri sampai akhirnya benar-benar melakukan tindakan yang mematikan (Fardiansyah, 2023).

B. Faktor Risiko Bunuh Diri Pada Remaja

Faktor risiko bunuh diri pada remaja, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Umum

Faktor umum yang dapat berisiko menjadi penyebab bunuh diri pada remaja yakni jenis kelamin (sebagian besar terjadi pada wanita), usia (sebagian besar terjadi pada usia 16-18 tahun), kemampuan akademik yang kurang, ekonomi lemah (Kwon et al., 2022).

2. Faktor Fisik

Faktor fisik yang dapat berisiko menjadi penyebab bunuh diri adalah sebagai berikut:

- a. Kecanduan alkohol dan Penyalahgunaan obat-obatan
Bila obat-obatan dan alkohol digunakan pada remaja yang depresi, keduanya dapat menjadi kombinasi yang mematikan untuk memicu bunuh diri. Obat-obatan, termasuk yang disebut "obat-obatan rekreasional", dapat menyebabkan episode psikotik dengan halusinasi dan delusi yang kemudian dapat menyebabkan bunuh diri. Di bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol, seorang remaja juga dapat mengembangkan kekeruhan kesadarannya dengan akibat hilangnya penilaian dan peningkatan perilaku mengambil risiko. Kematian karena kecelakaan dapat terjadi (Nevada Division of Public and Behavioral Health (DPBH) Office of Suicide Prevention, 2021).
- b. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual merupakan salah satu faktor risiko bunuh diri. Para korban kekerasan seksual sering bertindak agresif, melukai diri sendiri, merusak dirinya dan selanjutnya mengakhiri kehidupannya (Avelina, 2023).
- c. Penderita penyakit parah
Penyakit parah menjadi salah satu faktor penyebab bunuh diri. Penyakit parah seperti kanker, penyakit diabetes melitus hingga penyakit gagal ginjal kronik yang melakukan dialysis juga akan berdampak pada masalah kesehatan jiwa. Penyakit parah yang ditambah dengan keterbatasan biaya hingga menjadi beban keluarga bisa memunculkan rasa putus asa dan memicu keinginan bunuh diri (Avelina, 2023).

d. Berat badan

Masa remaja merupakan masa ketika terjadi perubahan tubuh yang penting, dan remaja semakin fokus pada tubuh dan penampilan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, gadis remaja berfokus pada tubuh yang kurus karena tren sosial yang menghargai kelangsingan. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki berat badan atau BMI normal, mereka mencoba untuk menurunkan berat badan, dan meskipun telah berupaya, mereka menjadi frustrasi jika mereka merasa tidak cukup langsing. Mengingat pentingnya masalah berat badan dan citra tubuh remaja serta potensinya untuk memicu pikiran bunuh diri, penting untuk mengatasi perasaan dan persepsi remaja tentang tubuh mereka (Kwon et al., 2022).

e. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik secara umum diketahui memiliki efek positif pada kesehatan mental melalui kecemasan, depresi, dan penghilang stres. Namun, dalam sebuah penelitian terhadap 136.857 remaja berusia 12-15 tahun dari 48 negara, tingkat aktivitas fisik yang tinggi ditemukan terkait dengan risiko yang lebih rendah dari percobaan bunuh diri pada anak laki-laki dan peningkatan risiko percobaan bunuh diri pada anak perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh masalah citra tubuh anak perempuan, di mana ketidakpuasan terhadap citra tubuh atau harga diri yang rendah mengakibatkan upaya untuk menurunkan berat badan melalui peningkatan aktivitas fisik dan olahraga. Hal ini juga dapat dianggap terkait dengan stres, dan anak perempuan lebih cenderung berolahraga berlebihan sebagai strategi penanganan aktif saat stres tinggi (29).

Oleh karena itu, anak perempuan yang stres dan memiliki citra tubuh yang negatif mungkin lebih cenderung aktif secara fisik, mungkin hingga tingkat yang berlebihan. Ini semua merupakan faktor risiko bunuh diri (Kwon et al., 2022).

3. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang dapat berisiko menjadi penyebab bunuh diri pada remaja adalah sebagai berikut:

a. Depresi

Perubahan suasana hati umum terjadi pada remaja tetapi suasana hati yang terus-menerus menurun atau tidak stabil dapat menunjukkan adanya depresi berat yang mendasarinya. Remaja yang depresi, terutama perempuan, memiliki risiko bunuh diri yang jauh lebih tinggi. Risiko bunuh diri semakin meningkat jika ada riwayat keluarga yang mengalami depresi dan bunuh diri. Gejala depresi sangat bervariasi, tergantung pada usia remaja. Semakin tua usia mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan mengalami gejala depresi seperti orang dewasa (Nevada Division of Public and Behavioral Health (DPBH) Office of Suicide Prevention, 2021).

b. Bullying

Pengalaman interpersonal merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap bunuh diri. Misalnya, pengalaman diabaikan dan/atau dikucilkan dapat memicu pikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu, bullying atau bullying sangat berpotensi terhadap kejadian bunuh diri remaja. Korban bullying merupakan kelompok rentan memiliki ide bunuh diri yang tinggi (Kwan et al., 2022).

c. Orientasi seksual

Berjuang dengan orientasi seksual di lingkungan yang tidak menghormati atau menerima orientasi tersebut. Masalahnya bukan apakah seorang anak gay atau lesbian tetapi apakah mereka berjuang untuk tampil di lingkungan yang tidak mendukung.

d. Gangguan jiwa

Gangguan jiwa seperti gangguan suasana hati seperti depresi, atau gangguan yang berhubungan dengan trauma dan stres; percobaan bunuh diri sebelumnya meningkatkan risiko percobaan bunuh diri lainnya; gangguan penggunaan alkohol dan zat lainnya, serta terlibat dalam banyak masalah, memiliki masalah disiplin, dan terlibat dalam banyak perilaku berisiko tinggi (Kaslow, 2024).

e. Kehilangan dan Berduka

Kehilangan yang baru saja terjadi atau serius. Ini mungkin termasuk kematian anggota keluarga, teman, atau hewan peliharaan. Perpisahan atau perceraian orang tua, atau putus cinta dengan pacar, juga dapat dirasakan sebagai kehilangan yang mendalam, bersama dengan orang tua yang kehilangan pekerjaan atau keluarga yang kehilangan rumah (Kaslow, 2024).

f. Gangguan perilaku dan faktor perilaku

Remaja dengan riwayat gangguan perilaku memiliki risiko bunuh diri yang jauh lebih tinggi karena mereka cenderung melampiaskan perasaan mereka dengan cara yang merusak. Hal ini khususnya berlaku jika mereka terisolasi, marah, agresif, impulsif, dan mereka menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol. Banyak dari anak muda ini berada dalam krisis yang konstan. Misalnya, mereka mungkin tunawisma dan mereka sering berkonflik dengan hukum karena kegiatan

antisosial mereka. Mereka ditolak oleh orang lain dan mereka mencari dukungan dari anak muda dengan latar belakang yang sama. Mereka mengambil risiko dalam apa yang mereka lakukan dan banyak dari mereka adalah individu yang mengalami depresi tetapi enggan mengakui kepada diri mereka sendiri atau orang lain tentang perasaan mereka yang sebenarnya atau meminta bantuan. Faktor perilaku lainnya mungkin meliputi: menulis catatan bunuh diri dan memilih metode bunuh diri; variasi dalam kinerja kerja atau gaya hidup sehari-hari; perilaku yang menunjukkan perasaan penolakan, penghinaan, keputusan atau isolasi; perilaku impulsif dan gangguan perilaku lainnya, termasuk kemarahan, amarah dan permusuhan; latar belakang keluarga yang mengganggu dan tidak mendukung (Nevada Division of Public and Behavioral Health (DPBH) Office of Suicide Prevention, 2021).

4. Faktor Sosial

a. Keluarga

Riwayat bunuh diri dalam keluarga adalah sesuatu yang dapat sangat signifikan dan mengkhawatirkan, seperti halnya riwayat kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, pelecehan anak, atau pengabaian (Kaslow, 2024; Kwon et al., 2022).

b. Kurangnya dukungan sosial

Seorang anak yang tidak merasakan dukungan dari orang dewasa yang berarti dalam hidupnya, serta teman-temannya, dapat menjadi sangat terisolasi sehingga bunuh diri tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar dari masalah mereka.

Penindasan. Kita tahu bahwa menjadi korban penindasan merupakan faktor risiko, tetapi ada juga beberapa bukti bahwa anak-anak yang menjadi penindas mungkin berisiko lebih tinggi untuk berperilaku bunuh diri (Kaslow, 2024).

c. Budaya dan agama

Keyakinan budaya dan agama bahwa bunuh diri adalah cara yang mulia untuk menyelesaikan dilema pribadi (Kaslow, 2024).

d. Hambatan untuk mengakses pelayanan

Kesulitan dalam mendapatkan layanan yang sangat dibutuhkan meliputi kurangnya penyedia layanan bilingual, transportasi yang tidak dapat diandalkan, dan biaya layanan yang mahal (Kaslow, 2024).

e. Stigma terkait permintaan bantuan

Hal yang perlu diketahui adalah bahwa semakin putus asa dan tidak berdaya orang tersebut, semakin besar kemungkinan mereka memilih untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup mereka. Demikian pula, jika mereka merasa sangat bersalah atau malu, atau jika mereka merasa tidak berharga atau memiliki harga diri yang rendah (Kaslow, 2024).

C. Deteksi Dini Resiko Bunuh Diri dan Asesmen Khusus Resiko Bunuh Diri

1. Deteksi Dini Resiko Bunuh Diri

Cara melakukan deteksi dini bunuh diri melalui wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor risiko bunuh diri, riwayat kesehatan pasien dan keluarga, tahapan bunuh diri dan tanda gejala bunuh diri dari pasien. Pengenalan faktor

risiko sangat penting bagi klinisi yang merawat pasien psikiatri rawat inap.

Petugas kesehatan harus cermat menilai kondisi pasien secara keseluruhan. Faktor-faktor yang harus dinilai adalah status mental terbaru, ide-ide terakhir mengenai kematian dan bunuh diri, rencana bunuh diri terbaru, seberapa siapa orang itu, dan sesegera apa aksi tersebut akan dijalankan, sistem pendukung individu. Selain wawancara juga dilakukan observasi tanda dan gejala dari pasien yang memiliki risiko bunuh diri, melakukan pemeriksaan status mental pasien secara menyeluruh. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk menentukan penyebab gejala. Memang, kondisi fisik tertentu, seperti penyakit tiroid atau kondisi neurologis, dapat menyebabkan gejala yang menyerupai gangguan mental. Dokter juga dapat melakukan tes darah, tes urin, dan scan otak pasien. Penyelidikan bertujuan untuk mengenali kemungkinan kondisi lain yang menghasilkan keinginan untuk mencoba bunuh diri (Avelina, 2023).

2. Asesmen Khusus Resiko Bunuh Diri

Assessment dapat menggunakan *tool* yang sudah divalidasi dan sudah disiapkan oleh pihak fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa instrumen yang digunakan sebagai asesmen risiko bunuh diri:

a. Ask Suicide Screening Questioning (ASQ)

Ask Suicide Screening Questioning (ASQ) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh NIMH (National Institute of Mental Health) pada tahun 2008 untuk mendeteksi bunuh diri pada remaja dan dewasa. ASQ terdiri dari empat pertanyaan dengan jawaban ya/tidak

yang sudah diseleksi dan memerlukan waktu 20 detik untuk menyelesaikannya (Avelina, 2023).

b. *Columbia Suicide Severity Scale* (C-SSRS)

Columbia Suicide Severity Scale (C-SSRS) yang dikembangkan oleh Posner, et.al (2011) yang diadaptasi dari Formulir sejarah bunuh diri Columbia. C-SSRS dirancang untuk a) memberikan definisi ide dan perilaku bunuh diri dan perilaku non bunuh diri yang merugikan diri sendiri; b) mengukur spektrum penuh dari ide bunuh diri dan perilaku bunuh diri dan mengukur tingkat keparahannya selama periode tertentu; c) membedakan perilaku bunuh diri dan perilaku tidak bunuh diri yang merugikan diri sendiri; dan d) menggunakan format yang ramah pengguna yang memungkinkan integrasi informasi dari berbagai sumber (misalnya, wawancara langsung dengan pasien, wawancara keluarga dan lainnya, dan wawancara medis) (Avelina, 2023).

c. *The Scale of Suicide Ideation* (SSI)

The Scale of Suicide Ideation (SSI) dikembangkan oleh Beck, Kovacs dan Weissman (1979). Menurut Beck et al. individu yang ingin bunuh diri didahului oleh ide untuk bunuh diri sehingga tepat untuk menilai bunuh diri dalam memprediksi risiko bunuh diri di kemudian hari. SSI adalah skala penilaian terdiri dari 19 item untuk mengukur tiga dimensi, yaitu *active suicidal desire* (12 item), persiapan (4 item) dan *passive suicidal desire* (3 item) (Avelina, 2023).

d. *SIRS (Suicidal Intention Rating Scale)*

SIRS (Suicidal Intention Rating Scale) yang dikembangkan oleh Balley dan Dreyer (1977). Melalui penilaian skor tersebut dokter ataupun tenaga

kesehatan profesional mampu mengidentifikasi pasien yang termasuk dalam risiko bunuh diri (Avelina, 2023).

e. *Self-Harm Inventory* (SHI) versi Indonesia

Upaya deteksi dini dan pencegahan perilaku *self-harm* penting untuk mencegah kematian dini akibat bunuh diri.

Instrumen *Self-harm Inventory* (SHI) pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat oleh Randy Sansone et al. pada tahun 2011 dalam Bahasa Inggris. Instrumen ini memiliki beberapa kelebihan dalam menilai aspek-aspek perilaku self-harm. Instrumen ini terdiri dari 22 item yang cukup singkat sehingga sesuai untuk menjangkau populasi dalam jumlah banyak (Avelina, 2023).

f. Instrumen Deteksi Dini Faktor Risiko Ide Bunuh Diri Remaja dari Nova Riyanti Yusuf

Instrumen ini dikembangkan oleh Dr. dr.Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ melalui hasil penelitian disertasinya pada tahun 2019 (Avelina, 2023).

D. Tanda dan Gejala Bunuh Diri

Tanda dan gejala yang ditemukan pada pasien dengan risiko bunuh diri adalah sebagai berikut:

1. Mengekspresikan ide atau kata-kata yang menunjukkan niat bunuh diri seperti "saya ingin mati" atau "saya lebih suka tidak pernah dilahirkan"
2. Membuat surat wasiat
3. Ucapan selamat tinggal kepada teman dan keluarga
4. Penyimpanan pil berbahaya atau senjata api
5. Mengonsumsi minuman beralkohol atau menggunakan NAPZA
6. Menjauhi keluarga

7. Tampak cemas atau gelisah
8. Mengalami penurunan kinerja yang drastis di sekolah dan tempat kerja
9. Mengalami perubahan dalam kebiasaan makan dan tidur
10. Menunjukkan perubahan suasana hati yang drastis seperti senang atau sangat senang tepat setelah mengalami kesedihan
11. Melakukan sesuatu yang berbahaya yang menyebabkan kematian seperti mengemudi dengan sangat cepat
12. Mengekspresikan rasa sakit baik emosional maupun fisik
13. Berbicara tentang rasa bersalah dan malu
14. Merasa membebani orang lain
15. Mengekspresikan perasaan hampa, putus asa dan tidak punya alasan untuk hidup
16. Mengekspresikan keinginan untuk mati atau bunuh diri
17. Sering berpikir atau berbicara tentang kematian
18. Menyakiti diri sendiri
19. Kehilangan minat dan semangat untuk hidup (Avelina, 2023)

E. Monitoring, Klasifikasi, dan Pertolongan Pertama (First Aid) Resiko Bunuh Diri

1. Monitoring dan Intervensi Dalam Pencegahan Bunuh Diri

- a. Pendekatan spiritual dalam mencegah resiko bunuh diri
Terapi spiritual merupakan suatu pengobatan dalam praktek keperawatan khususnya keperawatan jiwa yang menggunakan pendekatan keagamaan. Terapi

spiritual dapat meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh dalam menghadapi berbagai macam problem kehidupan yang merupakan stressor psikososial guna meningkatkan integritas kesehatan jiwa (Alfianto, 2023).

b. Penerapan konseling

Konseling merupakan suatu proses bantuan secara profesional antara konselor dan klien, konseling bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan masalahnya agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Manfaat terapi konseling diantaranya menurunkan atau menghilangkan stres, depresi sehingga dapat mencegah resiko bunuh diri (Alfianto, 2023).

c. Terapi CBT (*Cognitive Behaviour Therapy*)

Cognitive Behavior Therapy dikembangkan oleh dr. Aaron T. Beck, terapi ini merupakan intervensi yang paling tepat diberikan pada klien dengan risiko bunuh diri. CBT merupakan terapi yang bertujuan untuk mengubah kognitif atau persepsi klien terhadap masalahnya, dalam rangka melakukan perubahan emosi dan tingkah laku klien (Alfianto, 2023).

2. Klasifikasi Bunuh Diri

a. Ide bunuh diri (*suicide ideation*)

Ide bunuh diri adalah pikiran membunuh diri sendiri, baik yang dilaporkan sendiri atau dilaporkan kepada orang lain. Ide bunuh diri meliputi pemikiran atau fantasi langsung maupun tidak langsung untuk bunuh diri atau perilaku melukai diri sendiri yang diekspresikan secara verbal, disalurkan melalui tulisan

atau pekerjaan seni dengan maksud tertentu maupun memperlihatkan pemikiran bunuh diri (Alfianto, 2023).

b. Niat bunuh diri (*suicide intent*)

Sebuah komitmen dan keinginan pasien untuk meninggal dengan cara membunuh dirinya sendiri (Wuryaningsih, Emi Wuri; Windarwati, Heni Dwi; Dewi, Erti Ikhtiarini; Deviantony, Fitrio; Hadi, 2018) .

c. Rencana bunuh diri (*suicide plan*)

Sebuah strategi, menetapkan waktu dan sarana prasarana untuk melaksanakan tindakan membunuh dirinya sendiri (Wuryaningsih, Emi Wuri; Windarwati, Heni Dwi; Dewi, Erti Ikhtiarini; Deviantony, Fitrio; Hadi, 2018).

d. Ancaman bunuh diri (*suicide threats*)

Ungkapan secara langsung atau tulisan sebagai ekspresi dari niat melakukan bunuh diri namun tanpa adanya tindakan. Ancaman bunuh diri mungkin menunjukkan upaya terakhir untuk mendapatkan pertolongan agar dapat mengatasi masalah. Bunuh diri yang terjadi merupakan kegagalan koping dan mekanisme adaptif (Alfianto, 2023).

e. Isyarat bunuh diri (*suicide gesture*)

Tindakan langsung pada diri sendiri tanpa ada luka atau luka kecil dari seseorang yang tidak ada niat untuk mengakhiri hidupnya maupun mengharapkan untuk meninggal pada akhirnya. Bagaimanapun mereka telah melakukan cara dimana orang lain mengartikan tindakan tersebut seperti bermaksud untuk bunuh diri (Alfianto, 2023).

f. Percobaan bunuh diri (*suicide attempts*)

Percobaan bunuh diri merupakan tindakan secara langsung pada diri sendiri dimana terkadang

menyebabkan luka kecil atau besar dari seseorang yang berniat untuk menghadiri hidup atau dengan serius mencederai dirinya. Isyarat dan percobaan yang tidak berhasil dan kurang mematikan disebut dengan para suicidal behavior (Alfianto, 2023).

g. Bunuh diri selesai (*completed suicide*)

Kematian seseorang yang mengakhiri kehidupan dengan cara mereka sendiri dengan sadar berniat untuk mati sebagai gambaran bunuh diri selesai. Bagaimanapun, hal ini penting untuk jadi catatan bahwa bunuh diri pada dasarnya terkadang terjadi tanpa disadari tanpa adanya niat untuk mati (Alfianto, 2023).

3. Pertolongan Pertama Resiko Bunuh Diri

Konsep dari pertolongan pertama Bunuh diri dapat menggunakan pendekatan *Mental Health First Aid* (MHFA) yang berasal dari Australia.

Program MHFA adalah penerapan kelima aksi untuk mengenali dan mengelola tantangan kesehatan mental, yaitu ALGEE. Aksi ini adalah proses yang paling mudah dilakukan oleh orang awam dalam membantu dan mengenali gangguan kesehatan mental, proses tersebut adalah:

A: *Approach, assess and assist with any crisis* (Dekati, Kaji dan Bantu terkait masalah yang dialami)

Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan, mengkaji masalah yang dialami, dan berikan bantuan sesuai dengan masalah yang ditemukan, Ketika membantu, seseorang melalui krisis kesehatan mental, penting diperhatikan tanda-tanda pikiran dan perilaku bunuh diri, cedera diri non-bunuh

diri, atau bahaya lainnya. Beberapa tanda peringatan bunuh diri termasuk:

- a. Mengancam melukai atau membunuh diri sendiri;
- b. Mencari akses ke cara untuk melukai atau membunuh diri sendiri;
- c. Berbicara atau menulis tentang kematian atau bunuh diri;
- d. Merasa putus asa;
- e. Bertindak tidak sesuai norma sosial atau terlibat dalam kegiatan berisiko;
- f. Peningkatan penggunaan alkohol atau obat-obatan;
- g. Menghindar atau menjauhkan diri dari keluarga, teman, atau masyarakat;
- h. Tampil gelisah atau marah; dan
- i. Memiliki perubahan dramatis dalam suasana hati.

L: Listen non-judgmentally (Dengarkan dengan tanpa menghakimi)

Mendengarkan seseorang adalah tindakan yang penting. Hindari penilaian pribadi terhadap situasi orang tersebut. Pada umumnya individu yang mengalami perubahan emosi berpikir ingin didengarkan dengan empati sebelum dia ditawarkan solusi masalahnya. Seorang penolong, saat mendengarkan masalah perlu menggunakan keterampilan mendengarkan secara verbal dan non verbal. Keterampilan mendengarkan tersebut seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang dikatakannya dan berikan situasi yang membuat orang tersebut dapat mengungkapkan masalahnya dengan bebas tanpa merasa dihakimi.

G: Give Support and Information (Berikan dukungan dan informasi)

Dukungan yang bisa diberikan yakni dukungan emosional seperti berempati tentang apa yang mereka rasakan dan memberikan harapan pada mereka bahwa mereka dapat melalui masalah tersebut. Dukungan lainnya yakni memberikan bantuan praktis yang mungkin dibutuhkan pada saat itu. Sebagai penolong, dapat menanyakan apakah mereka membutuhkan informasi mengenai kesehatan jiwa?.

E: *Encourage appropriate professional help* (Dorong untuk mendapat bantuan profesional yang tepat)

Penolong dapat menyampaikan tentang pilihan bantuan dan dukungan yang tersedia. Seseorang dengan masalah kesehatan jiwa biasanya akan pulih lebih baik dengan bantuan profesional yang tepat. Dengan demikian, mereka harus tahu jenis pilihan terapi yang tersedia bagi mereka. Pada umumnya, tersedia banyak profesional yang menawarkan bantuan ketika seseorang dalam keadaan krisis atau mungkin mengalami tanda-tanda dan gejala gangguan mental. Jenis-jenis profesional tersebut yakni:

- a. Dokter (dokter perawatan primer atau psikiater);
- b. Pekerja sosial, konselor, dan profesional kesehatan jiwa lainnya; dan
- c. Spesialis kesehatan jiwa tersertifikasi.

Jenis bantuan yang diberikan oleh profesional yakni:

- a. Terapi "bicara"; dan
- b. Terapi obat.

E: *Encourage other support* (Dorong untuk mendapat bantuan lainnya)

Dorong seseorang yang mengalami masalah kesehatan jiwa untuk menggali strategi pemecahan masalah pada diri sendiri dan mencari bantuan kepada

keluarga, teman, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami masalah kesehatan jiwa juga mampu memberikan pertolongan yang berharga pada masa pemulihan. Masalah kesehatan jiwa dapat dialami oleh siapapun di seluruh dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk mempelajari dasar-dasar pertolongan pertama pada masalah kesehatan jiwa (Alfianto, 2023).

F. Dampak Bunuh Diri

Dampak yang akan terjadi setelah terjadinya kasus bunuh diri menurut Wicaksana (2016) dalam Patemah (2023):

1. Terjadinya trauma pada orang-orang terdekat maupun lingkungan sekitarnya

Trauma yang terjadi ini menimbulkan gangguan psikologis pada keluarga yang ditinggalkan. Gangguan psikis seperti keluarga akan menutup diri dari kehidupan sosial yang ada di masyarakat, menjauhi masyarakat di sekelilingnya, malu bertemu orang lain karena takut ditanya-tanya tentang kejadian bunuh diri, emosi yang tidak terkontrol sehingga mudah marah, merasa dikucilkan atau dibenci saudaranya atau masyarakat di sekitarnya, bersikap waspada atau menjaga jarak dengan orang lain, dan lain-lain. Kondisi seperti ini dapat memicu kejadian bunuh pada keluarga karena tidak sanggup menerima pertanyaan atau cibiran dari orang lain atau lingkungan sekitar.

2. Timbulnya fitnah pada masyarakat secara luas, yang akan menyebabkan penilaian negatif terhadap lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan sebagainya

Adanya cerita tentang kejadian bunuh diri yang ada di lingkungan masyarakat akan mudah tersebar luas

dengan kemajuan teknologi. Berita yang tersebar luas tersebut akan menjadi berbeda Ketika diceritakan oleh satu orang kepada yang lain. Hal ini akan membuat berita baru yang kesimpulannya dapat menjadi fitnah dan meresahkan masyarakat.

3. Kejadian bunuh diri pada suatu tempat akan berhubungan dengan nilai ekonomi yang bersangkutan dengan harga jual suatu produk ataupun jasa

Apabila kejadian bunuh diri terjadi di suatu bangunan seperti hotel dan kos, maka hal itu akan menurunkan harga jual dari properti tersebut. Orang yang mengetahui kasus bunuh diri di tempat tersebut akan berpikir dua kali untuk menyewa ataupun membeli tempat tersebut. Pembeli atau pengguna akan memilih menolak karena takut atau masih teringat kejadian bunuh diri pada saat itu. Jika kejadian bunuh diri terjadi di lingkungan sekolah maka dampak negatif juga akan dialami oleh sekolah tersebut, dimana orang tua akan takut menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut sehingga akan berdampak terhadap penurunan jumlah siswa di sekolah tersebut. Selain itu, seluruh siswa ataupun guru cenderung menghindari lokasi bunuh di lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian akan menurunkan sumber daya tempat yang akan merugikan tempat itu.

4. Timbulnya pemahaman yang berbahaya

Pesan ini kadang akan menimbulkan komentar dan pemahaman yang berbahaya karena akan menimbulkan pandangan negatif untuk keberlangsungan hidup manusia, dalam hal ini akan memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pemahaman tentang kejadian bunuh diri yang salah oleh masyarakat ataupun orang-

orang yang ada di tempat kejadian perlu mendapatkan pemantauan dan pendampingan dari tenaga profesional. Pandangan dan pemahaman yang berbahaya ini akan menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, jika ada kasus kematian dengan bunuh diri perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan pada keluarga terdekat, masyarakat yang ada di wilayah tersebut, dan orang-orang yang melihat kejadian atau menemukan kasus bunuh diri.

5. Orang yang bunuh diri dianggap lari dari tanggung jawab

Kejadian bunuh diri yang ada kaitannya dengan harta hutang piutang biasanya akan menimbulkan permasalahan hukum. Keluarga yang ditinggalkan akan terbebani dengan hutang piutang yang mereka tidak tahu sebelumnya tetapi harus bertanggung jawab dan menanggung akibatnya (Patemah, 2023).

BAB 4

EVIDANCED BASED PRACTICE

A. Pengertian Evidence-Based Practice

Evidence-based practice (EBP) adalah proses yang digunakan untuk meninjau, menganalisis, dan menerjemahkan bukti ilmiah terbaru. EBP adalah landasan praktik klinis. Mengintegrasikan EBP ke dalam praktik keperawatan Anda meningkatkan kualitas perawatan dan hasil pasien (John Hopkins, 2023).

B. Tujuan dan Manfaat Evidence-Based Practice

1. Tujuan Evidence-Based Practice

adanya Evidence-Based Practice adalah untuk segera menggabungkan penelitian terbaik yang tersedia, bersama dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien, ke dalam praktik klinis, sehingga perawat dapat membuat keputusan perawatan pasien yang tepat (John Hopkins, 2023).

2. Manfaat Evidence-Based Practice

Evidence-Based Practice membantu perawat membangun pengetahuan mereka sendiri, meminimalkan kesenjangan antara pendidikan keperawatan, penelitian, dan praktik, menstandarisasi praktik keperawatan, meningkatkan hasil klinis pasien, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan menurunkan biaya layanan kesehatan. Dengan demikian, pengambilan keputusan klinis oleh perawat harus didasarkan pada bukti penelitian terbaik dan terkini yang tersedia (Abu-Baker et al., 2021).

C. Evidence-Based Practice Bullying dengan Resiko Bunuh Diri Remaja

Artikel ilmiah terkait bullying dengan resiko bunuh diri remaja banyak ditemukan. Artikel ilmiah tersebut dapat berupa *original research*, *literature-review*, *meta-analysis* baik di Indonesia maupun luar negeri. Artikel ilmiah yang berkaitan tersebut diantaranya:

1. Yosep, et al. (2024) meneliti tentang "The relationship between bullying and risk of suicide among adolescents during the covid 19 pandemic in Indonesia". Desain penelitian menggunakan cross-sectional dilakukan pada remaja berusia 14–18 tahun pada bulan Mei 2020 di Bandung, Indonesia, menggunakan survei tertutup berbasis web. Instrumen Hubungan Antarteman Remaja dan Kuesioner Perilaku Bunuh Diri yang Direvisi digunakan untuk mengukur bullying dan risiko bunuh diri. Analisis regresi logistik multinomial dilakukan. Penelitian ini melibatkan 268 partisipan pada tahun 2020 dan 175 partisipan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, prevalensi pelaku dan korban bullying secara gabungan adalah 74,6%. Sementara itu, pada tahun 2019, prevalensi pelaku dan korban bullying secara gabungan adalah 82,9%. Risiko bunuh diri meningkat dari 26,1% pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19) menjadi 36,5% pada tahun 2020 (selama gelombang pertama pandemi COVID-19). Risiko pelaku dan korban bunuh diri lebih tinggi daripada risiko pelaku dan korban saja (rasio peluang [OR] = 4,0, interval kepercayaan [CI] 95% = 1,5–6,6 vs. OR = 1,3, 95% CI = 1,0–2,9 dan OR = 1,6, 95% CI = 1,1–2,8, berturut-turut)(Yosep et al., 2024).
2. Yanzami & Widyastuti (2021) meneliti tentang "Bullying berhubungan dengan resiko bunuh diri remaja". Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan korban *bullying* dengan risiko bunuh diri pada remaja di Pancoran Mas Depok. Penelitian ini melibatkan 220 siswa dengan tingkat pendidikan SMP, SMA dan SMK. Peneliti menggunakan Bullying Participant Behavior Questionnaire untuk mengukur kejadian bullying dan Columbia Suicide Severity Rating Scale untuk mengukur risiko bunuh diri pada responden. Sehubungan dengan banyaknya sekolah yang diliburkan karena pandemi COVID-19 yang melanda, peneliti mengumpulkan data secara online melalui google form. Penelitian ini menggunakan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Berdasarkan hasil uji one way anova p value = 0,000 artinya ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara korban bullying dengan risiko bunuh diri pada remaja. Pelaksanaan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi korban *bullying* dan risiko bunuh diri pada remaja di sekolah (Yanzami, 2021).

3. Syamsul et al. (2024) membuat kajian literature review tentang "Hubungan antara bullying dengan kejadian bunuh diri di kalangan remaja". Tujuan penelitian ini Menganalisis hubungan antara bullying dengan kejadian bunuh diri di kalangan remaja berdasarkan literatur terkini melalui tinjauan sistematis. Metode dengan tinjauan sistematis dilakukan mengikuti pedoman PRISMA. Pencarian literatur dilakukan pada database PubMed, SCOPUS, PsycINFO, dan Google Scholar untuk artikel yang diterbitkan antara 2019-2024. Kata kunci meliputi "bullying", "suicide", "adolescents", dan variasinya. Dari 312 artikel yang diidentifikasi, 20 artikel memenuhi kriteria inklusi setelah melalui proses penyaringan dan kelayakan.

Hasil Analisis terhadap 20 artikel terpilih mengonfirmasi hubungan yang signifikan antara bullying dan peningkatan risiko bunuh diri di kalangan remaja. Temuan terbaru menunjukkan Peningkatan dampak cyberbullying terhadap risiko bunuh diri, terutama selama pandemi COVID-19, Efek kumulatif dari berbagai jenis bullying yang semakin meningkatkan risiko, Pentingnya faktor pelindung seperti dukungan keluarga dan resiliensi dalam memitigasi risiko bunuh diri dan Efektivitas intervensi berbasis sekolah dan online dalam mengurangi dampak bullying. Kesimpulan Tinjauan sistematis ini menegaskan kembali hubungan kuat antara bullying dan risiko bunuh diri di kalangan remaja, dengan penekanan pada tren terbaru seperti meningkatnya pengaruh cyberbullying. Temuan ini menekankan urgensi pengembangan strategi pencegahan dan intervensi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial remaja. Diperlukan penelitian longitudinal untuk lebih memahami dampak jangka panjang dan efektivitas intervensi dalam konteks yang terus berubah (Tri Damayanty Syamsul; Lala Lala; Kasmawati Karim; Dia rejeki utami;Elvira Safidni, 2024).

4. Li, et al. (2024) membuat meta-analysis tentang "Traditional bullying and cyberbullying in the digital age and its associated mental health problems in children and adolescents". Tujuan dilakukan meta analisis untuk mengeksplorasi efek unik dan gabungan dari CB dan TB terhadap hasil psikologis yang merugikan pada korban dengan melakukan studi gabungan dari kedua jenis bullying tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, kami menyediakan dasar untuk program pencegahan bullying komunitas yang komprehensif. Basis data PubMed, PsycINFO, dan Web of Science ditelusuri untuk studi dari

tahun 2010 hingga 2021. Pedoman pelaporan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) diikuti untuk abstraksi data, dan alat NIH digunakan untuk mengevaluasi risiko bias pada tingkat studi. Sebanyak 42 studi dengan 266.888 partisipan diidentifikasi. Model Efek Acak digunakan untuk studi kami. Analisis moderator digunakan untuk mengeksplorasi moderator prevalensi. Studi dengan tiga kelompok korban (hanya TB, hanya CB, dan Keduanya) dan dua kelompok korban (TB dan CB) dibandingkan dalam analisis subkelompok. Rata-rata tingkat viktimisasi adalah 24,32% (95% CI 20,32–28,83%) untuk TB dan 11,10% (95% CI 9,12–13,44%) untuk CB. Sekitar sepertiga korban TB juga menjadi korban CB. Sebaliknya, hanya sekitar sepertiga korban CB yang bebas dari TB. Perkiraan OR untuk depresi, ide bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan melukai diri sendiri dalam analisis tiga kelompok (hanya TB, hanya CB, dan Keduanya) adalah: depresi [hanya TB: 3,33 (2,22–5,00); hanya CB: 3,38 (2,57–4,46); Keduanya: 5,30 (2,43–11,56)]; ide bunuh diri [hanya TB: 3,08 (2,12–4,46); hanya CB: 3,52 (2,38–5,20); Keduanya: 6,64 (4,14–10,64)]; menyakiti diri sendiri [hanya TB: 2,70 (1,86–3,91); hanya CB: 3,57 (3,20–3,98); Keduanya: 5,57 (2,11–16,00)]; dan percobaan bunuh diri: [hanya TB: 2,61 (1,50–4,55); hanya CB: 3,52 (2,50–4,98); Keduanya: 7,82 (3,83–15,93)]. Korban TB dan CB di kalangan remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat. Viktimisasi tampaknya menjadi penanda keparahan psikopatologis yang lebih besar, khususnya masalah yang berhubungan dengan bunuh diri (Li et al., 2022).

5. Dewi, et al. (2023) meneliti tentang "The relationship between cyberbullying and the risk of suicidal ideation in

adolescents". Tujuan untuk menganalisis hubungan antara cyberbullying dengan risiko ide bunuh diri pada remaja. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan cross-sectional terhadap 1043 siswa dari sepuluh SMA negeri dan empat SMK negeri dengan random sampling. Keterlibatan remaja dalam cyberbullying diukur menggunakan The Second revision of the revision cyberbullying inventory-II (RCBI-II) dan risiko ide bunuh diri pada remaja diukur menggunakan instrumen Risk Factors of Suicidal Ideation (RFSI). Analisis data dalam penelitian menggunakan uji Chi-Square, uji kruskal-wallis, dan uji Mann-Whitney. Hasil: Sebanyak 21,0% remaja yang terlibat dalam cyberbullying berisiko ide bunuh diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara cyberbullying dengan risiko ide bunuh diri pada remaja $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Kesimpulan: Risiko munculnya ide bunuh diri tidak hanya terjadi pada remaja yang terlibat sebagai korban cyberbullying, tetapi juga pada remaja yang terlibat sebagai pelaku (Dewi et al., 2023).

D. Evidence-Based Practice Intervensi Bullying di Sekolah

Artikel ilmiah terkait intervensi bullying di sekolah banyak ditemukan. Artikel ilmiah tersebut dapat berupa *original research*, *systematic-review*, *meta-analysis* baik di Indonesia maupun luar negeri.

1. Norman (2020) meneliti tentang "Tackling bullying from the inside out: shifting paradigms in bullying research and interventions". Tujuan penelitian adalah menjelaskan penerapan sosiologi masa anak-anak untuk mengatasi bullying di sekolah. Perspektif sosiologi 'baru' menekankan 'pluralitas masa kanak-kanak' tidak hanya

dalam masyarakat yang sama, tetapi juga di seluruh lingkungan tempat anak-anak menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Anak-anak di lokasi sosial yang berbeda memiliki masa kanak-kanak yang berbeda dan bahwa pengalaman mereka tentang masa kanak-kanak berubah dari satu konteks ke konteks lainnya. Anak-anak tidak semuanya sama dalam setiap situasi dan konteks. Intervensi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengurangi bullying adalah kepemimpinan dan manajemen lingkungan sekolah (mengubah iklim sekolah negatif menjadi positif), pengembangan kebijakan terkait program anti bullying, perencanaan kurikulum yang memuat tentang program anti bullying, bimbingan dan konseling, dan kemitraan dengan orang tua dan masyarakat (O'Higgins Norman, 2020).

2. Rigby (2020) meneliti tentang "How teachers deal with cases of bullying at school: what victims say". Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang menurut siswa yang menjadi korban dilakukan sekolah setelah mereka mencari bantuan dari seorang guru. Metode yang digunakan adalah survei yang dilakukan secara daring dengan sampel siswa Australia yang menghadiri pendidikan campuran sekolah negeri pada tahun 2015–2016. Data penelitian yang dilaporkan dalam artikel ini merupakan bagian dari studi yang didanai pemerintah mengenai prevalensi dan efektivitas strategi anti-bullying yang digunakan di sekolah-sekolah Australia. Hasil penelitian: Tindakan yang dilaporkan oleh siswa mencakup rentang yang luas dengan lebih dari 50% siswa melaporkan bahwa sanksi dalam bentuk tertentu (terutama teguran lisan) digunakan. Selain itu, guru memberikan saran tentang cara mengatasi bullying;

beberapa bentuk penyelesaian konflik, seperti praktik pemulihan, dilakukan; dan setelah intervensi, guru memantau apa yang terjadi selanjutnya. Sekitar 40% siswa melaporkan bahwa orang tua dari mereka yang terlibat dalam bullying juga terlibat.

Intervensi yang perlu dilakukan oleh guru yakni hadapi dan berikan sanksi kepada pelaku bully; membantu korban mengatasi masalah; berkomunikasi dengan orang tua; melakukan penyelesaian konflik; mencari bantuan di luar sekolah (psikolog dan polisi); memantau perilaku siswa; dan bekerja dengan siswa (Rigby, 2020).

3. Hensums, et al. (2023) membuat meta-analisis tentang "What works for whom in school-based anti-bullying interventions? an individual participant data. meta-analisis data partisipan individu (IPD) skala besar menggunakan data dari 39.793 anak-anak dan remaja berusia lima hingga 20 tahun ($Mage = 12,58$, $SD = 2,34$) yang telah berpartisipasi dalam uji coba kuasi-eksperimental atau acak terkontrol dari intervensi antibullying berbasis sekolah (yaitu, 10 studi yang menguji sembilan intervensi). Analisis regresi logistik multilevel menunjukkan bahwa intervensi antibullying secara signifikan mengurangi viktimisasi yang dilaporkan sendiri ($d = -0,14$) dan perilaku bullying ($d = -0,07$). Intervensi anti-bullying lebih kuat mengurangi tindak bullying pada peserta yang lebih muda (yaitu, di bawah usia 12 tahun) dan viktimisasi bagi remaja yang lebih banyak menjadi korban sebelum intervensi. Kami tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa penyertaan komponen intervensi tertentu berkaitan dengan efek intervensi keseluruhan yang lebih tinggi, kecuali untuk efek iatrogenik dari metode disiplin non-hukuman yang paling kuat untuk

anak perempuan. Analisis eksploratif menunjukkan bahwa pertemuan sekolah dan pengawasan taman bermain mungkin memiliki efek berbahaya bagi sebagian orang, meningkatkan tindak bullying pada remaja yang sudah sering melakukan bullying di awal (Hensums et al., 2023).

4. Yosep, et al. (2022) meneliti tentang "Method of nursing interventions to reduce the incidence of bullying and its impact on students in school: A scoping review". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan intervensi keperawatan untuk mengurangi kejadian bullying dan dampaknya terhadap siswa di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode scoping review dan tinjauan pustaka melalui database CINAHL, PubMed, dan ProQuest. Kata kunci yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah "bullying OR cyberbullying OR degradation" AND "students OR school students" AND "school OR schools" AND "nursing intervention". Kriteria untuk artikel dalam penelitian ini adalah: teks lengkap, populasi dan sampel siswa, uji coba kontrol acak atau desain penelitian kuasi-eksperimen, penggunaan bahasa Inggris, dan periode publikasi 10 tahun terakhir (2013–2022). Kami menemukan 11 artikel yang membahas intervensi keperawatan untuk mengurangi kejadian bullying dan dampaknya pada siswa di sekolah. Ada empat jenis intervensi yang dapat diberikan kepada siswa, yaitu, program pencegahan, program kegiatan, program kelompok sebaya, dan program ketahanan. Sebagian besar artikel menggunakan uji coba kontrol acak dan desain eksperimen semu. Sampel dalam artikel yang dianalisis berada dalam kisaran 50–7121 siswa. Keempat jenis intervensi ini dapat mengurangi kejadian bullying dan dampaknya pada siswa di sekolah, dan sebagai

tambahan, mereka dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesehatan mental siswa, misalnya, dengan meningkatkan efikasi diri, ketahanan, dan koping adaptif mereka. Ada empat intervensi keperawatan untuk mengurangi kejadian bullying dan dampaknya pada siswa di sekolah, yaitu, program pencegahan, program kegiatan, program kelompok sebaya, dan program ketahanan (Yosep, Iyus, Rohman Hikmat, Ai Mardhiah, 2022).

5. Yosep, et al. (2023) meneliti tentang "School-based nursing interventions for preventing bullying: A scoping review". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan intervensi keperawatan berbasis sekolah dalam mencegah dan mengurangi kejadian bullying di kalangan siswa di sekolah. Penelitian ini menggunakan scoping review dengan strategi pencarian menggunakan proses PRISMA Extension for Scoping Review untuk menemukan artikel. Pencarian dilakukan pada basis data elektronik PubMed, CINAHL, dan Scopus. Kami menemukan 12 artikel dari 594 artikel dalam 3 basis data yang membahas intervensi keperawatan berbasis sekolah untuk mencegah dan mengurangi kejadian bullying pada siswa. Penelitian yang dilakukan adalah desain uji coba terkontrol acak dan eksperimen semu. Sampel dengan rentang 40–7121 responden. Kami mengklasifikasikan intervensi keperawatan berbasis sekolah menjadi tiga metode, yaitu program permainan, program aktivitas fisik, program pelatihan, dan program kelompok sebaya. Konten intervensi adalah psikoedukasi, pelatihan empati, konseling, dan manajemen diri. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berbasis sekolah dapat menjadi pilihan dalam mencegah dan

mengurangi kejadian bullying di kalangan siswa di sekolah (Yosep et al., 2023).

6. Campos, et al. (2021) meneliti tentang "The zero violence brave club: A successful intervention to prevent and address bullying in schools". Bullying di antara teman sebaya di sekolah merupakan masalah yang terus berkembang yang memengaruhi anak-anak dan remaja sejak usia dini di seluruh dunia. Konsekuensi dari penindasan terhadap perkembangan emosional anak-anak dan remaja serta prestasi akademik mereka merugikan mereka dan seluruh komunitas sekolah, dengan dampak negatifnya meluas hingga jangka menengah dan panjang. Klub Berani Tanpa Kekerasan diterapkan di sekolah-sekolah dalam kerangka Model Dialogis Pencegahan Kekerasan, sebuah tindakan pendidikan yang berhasil menurut proyek INCLUD-ED [Strategi untuk inklusi dan kohesi sosial di Eropa dari Pendidikan] (Program Kerangka Penelitian ke-6 Komisi Eropa). Klub Berani Tanpa Kekerasan telah mengurangi bullying antarteman di sekolah dengan membangun dan menumbuhkan budaya toleransi nol terhadap kekerasan di pusat-pusat pendidikan yang berlokasi dalam konteks sosial ekonomi dan budaya yang beragam. Intervensi berbasis bukti ini didasarkan pada prinsip bahwa hanya orang yang mencela kekerasan yang dialami oleh teman sebaya dan selalu berpihak pada korban—dan mereka yang mendukungnya—melawan pelaku kekerasan yang dapat dianggap berani. Artikel ini melaporkan studi kualitatif tentang Zero Violence Brave Club sebagai intervensi yang berhasil di tujuh sekolah di Spanyol. Sekolah-sekolah tersebut beragam dalam hal kepemilikan publik atau swasta, latar belakang agama atau awam, dan

populasi yang dilayani (proporsi yang berbeda dari kelompok minoritas budaya dan siswa dengan kebutuhan khusus), yang menantang kesalahpahaman bahwa dampak intervensi pendidikan bergantung pada konteksnya. Wawancara dilakukan dengan guru-guru di sekolah-sekolah yang menerapkan Zero Violence Brave Club di kelas mereka, menggunakan metodologi penelitian komunikatif. Hasilnya menjelaskan mekanisme khusus yang digunakan Zero Violence Brave Club untuk mencegah dan menanggapi bullying di sekolah, seperti menghilangkan daya tarik sosial dari perilaku atau sikap agresif apa pun. Manfaat pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis juga dilaporkan (Roca-Campos et al., 2021).

BAB 5

PENUTUP

Bullying di sekolah merupakan bullying yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Faktor resiko terjadinya bullying di sekolah terdiri dari beberapa faktor yakni faktor individual (jenis kelamin, usia, tingkatan kelas, suku bangsa, status sosial ekonomi, karakteristik yakni berat badan dan keterampilan motorik, perilaku eksternalisasi, harga diri, popularitas dan keterampilan sosial, prestasi akademik, disabilitas fisik, dan pengendalian diri), faktor teman sebaya (norma kelompok sebaya, sikap permisif, kenakalan dan perilaku antisosial, penggunaan alkohol dan narkoba), faktor sekolah (iklim sekolah, sikap guru, karakteristik kelas, dan rasa memiliki sekolah), faktor keluarga (pola asuh dan konflik keluarga), faktor sosial (sosial media), dan faktor komunitas (lingkungan sekitar). Bullying dalam pelaksanaannya terdiri dari empat bentuk yakni bullying verbal, bullying fisik, bullying relasional, dan bullying elektronik. Dampak yang timbul dari perilaku bullying lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap pelaku, korban, dan saksi. Dampak bullying secara kognitif, psikologis, dan sosial dari pelaku, korban, dan saksi.

Bunuh diri pada remaja merupakan suatu tindakan mengakhiri kehidupan yang dilakukan secara sadar karena berbagai faktor. Beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan resiko bunuh diri pada remaja adalah faktor umum (usia, jenis kelamin, kemampuan akademik, dan ekonomi keluarga), faktor fisik (kecanduan alkohol dan

penyalahgunaan obat-obatan, kekerasan seksual, penderita penyakit parah, berat badan, dan aktivitas fisik), faktor psikologis (depresi, bullying, orientasi seksual, gangguan jiwa, kehilangan dan berduka, gangguan perilaku dan faktor perilaku), faktor sosial (keluarga, kurang dukungan sosial, budaya dan agama, hambatan untuk mengakses pelayanan, dan stigma terkait permintaan bantuan). Resiko bunuh diri pada remaja dapat diidentifikasi menggunakan beberapa instrument seperti *Ask Suicide Screening Questioning* (ASQ), *Columbia Suicide Severity Scale* (C-SSRS), *The Scale of Suicide Ideation* (SSI), *SIRS* (*Suicidal Intention Rating Scale*), dan *Self-harm Inventory* (SHI).

Tahapan upaya bunuh diri yakni ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, isyarat bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan bunuh diri selesai. Upaya pencegahan resiko bunuh diri dapat menggunakan beberapa teknik yakni pendekatan spiritual, penerapan konseling, dan terapi CBT (*Cognitive Behaviour Therapy*). Pertolongan pertama pada individu dengan bunuh diri yakni menggunakan pendekatan *Mental Health First Aid* (MHFA) yang berasal dari Australia. Program MHFA adalah penerapan kelima aksi untuk mengenali dan mengelola tantangan kesehatan mental, yaitu ALGEE (*A: Approach, assess and assist with any crisis; L: Listen non-judgmentally; G: Give Support and Information; E: Encourage appropriate professional help; dan E: Encourage other support*).

Evidence-Based Practice yang disajikan dalam buku ini tentang bullying dan resiko bunuh diri pada remaja serta intervensi untuk mencegah bullying di sekolah. Evidence-Based Practice ini berasal dari original research, systematic review, dan meta analysis,

Penulis telah menyusun buku ini dengan metode dan bahasa yang mudah dipahami sehingga diharapkan para pembaca dapat memahami dan dapat mengaplikasikan intervensi pencegahan bullying di sekolah sehingga dapat membantu mengurangi dan menghilangkan bullying di sekolah serta meningkatkan kesehatan jiwa semua yang terlibat dalam perilaku bullying.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Baker, N. N., AbuAlrub, S., Obeidat, R. F., & Assmairan, K. (2021). Evidence-based practice beliefs and implementations: a cross-sectional study among undergraduate nursing students. *BMC Nursing*, 20(1), 4–11. <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00522-x>
- Ahmed, G. K., Metwaly, N. A., Elbeh, K., Galal, M. S., & Shaaban, I. (2022). Risk factors of school bullying and its relationship with psychiatric comorbidities: a literature review. *Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery*, 58(1). <https://doi.org/10.1186/s41983-022-00449-x>
- Alfianto, A. G. (2023). Monitoring, Klasifikasi, dan Pertolongan Pertama (First Aid) Resiko Bunuh Diri. In M. Martini (Ed.), *Buletin Penelitian Kesehatan* (pp. 69–86).
- Alwi, N. A., Dona, T. R., Nasution, D. E., & Lestari, E. E. (2023). Why Do Students Engage in Bullying? Other Factors Found To Contribute To Student Bullying. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 8(2), 161–171. <https://doi.org/10.26740/jp.v8n2.p161-171>
- Avelina, Y. (2023). Deteksi Dini Bunuh Diri dan Asesmen Khusus Risiko Bunuh Diri. In M. Martini (Ed.), *Bunuh Diri* (pp. 47–62). Media Sains Indonesia.
- Coloroso, B. (2020). The Bully, The Bullied, and The Not So Innocent By Stander. *Happers Collins Publisher.Inc*.
- Danielien A. E. van Aalst; Gijs Huitsing & René Veenstra. (2024). A Systematic Review on Primary School Teachers' Characteristics and Behaviors in Identifying,

Preventing, and Reducing Bullying. *International Journal of Bullying Prevention*, 6(1), 124–137.
https://link.springer.com/article/10.1007/s42380-022-00145-7?trk=public_post_main-feed-card_feed-article-content

Dewi, H. A., Suryani, S., & Sriati, A. (2023). The relationship between cyberbullying and the risk of suicidal ideation in adolescents. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 11(2), 118–123.
<https://doi.org/10.24198/jkp.v11i2.2259>

Fardiansyah, H. (2023). Insiden dan Prevalensi Kasus Bunuh Diri Secara Global. In M. Martini (Ed.), *Bunuh Diri* (pp. 1–10). Media Sains Indonesia.

Farrington, D. P. (2020). The importance of risk factors for bullying perpetration and victimization. *Jornal de Pediatria*, 96(6), 667–669.
<https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.04.003>

Francis, J., Strobel, N., Trapp, G., Pearce, N., Vaz, S., Christian, H., Runions, K., Martin, K., & Cross, D. (2022). How does the school built environment impact students' bullying behaviour? A scoping review. *Social Science and Medicine*, 314(October).
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115451>

Hannah Gaffney, Maria M. Ttofi, D. P. F. (2021). *Campbell Systematic Reviews - 2021 - Gaffney - Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and.pdf*. 1–102.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cl2.1143>

Hensums, M., de Mooij, B., Kuijper, S. C., Cross, D., DeSmet, A.,

- Garandeau, C. F., Joronen, K., Leadbeater, B., Menesini, E., Palladino, B. E., Salmivalli, C., Solomontos-Kountouri, O., Veenstra, R., Fekkes, M., & Overbeek, G. (2023). What Works for Whom in School-Based Anti-bullying Interventions? An Individual Participant Data Meta-analysis. *Prevention Science*, 24(8), 1435–1446. <https://doi.org/10.1007/s11121-022-01387-z>
- Johansson, B. (2023). *Risk and protective factors of school bullying-A scoping review* Editors: Björn Johansson and Daniel Uhnoo (Björn Johansson and Daniel Uhnoo (ed.)). Örebro University. www.oru.se/publikationer
- John Hopkins. (2023). *Evidence-Based Practice*. John Hopkins Nursing. [https://www.hopkinsmedicine.org/nursing/center-nursing-inquiry/nursing-inquiry/evidence-based-practice#:~:text=EBP is a process used,et al.%2C 2022\).](https://www.hopkinsmedicine.org/nursing/center-nursing-inquiry/nursing-inquiry/evidence-based-practice#:~:text=EBP is a process used,et al.%2C 2022))
- Kaslow, N. (2024). *Teen Suicides: What Are the Risk Factors?* Child Mind Institute. <https://childmind.org/article/teen-suicides-risk-factors/>
- Kwan, C., Wong, C., Chen, Z., & Yip, P. S. F. (2022). Youth Bullying and Suicide: Risk and Protective Factor Profiles for Bullies, Victims, Bully-Victims and the Uninvolved. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph19052828>
- Kwon, M., Kim, S. A., & Seo, K. (2022). Factors Influencing Suicide

Attempts of Adolescents with Suicidal Thoughts in South Korea: Using the 15th Korean Youth Risk Behavior Web-Based Survey (KYRBS). *Iranian Journal of Public Health*, 51(9), 1990–1998. <https://doi.org/10.18502/ijph.v51i9.10553>

Li, C., Wang, P., Martin-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H. (2022). Traditional bullying and cyberbullying in the digital age and its associated mental health problems in children and adolescents: a meta-analysis. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 33(9), 2895–2909. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02128-x>

Medicine, N. L. O. (2019). Consequences of Bullying Behavior. In *Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice*. NCBI. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390414/>

Nevada Division of Public and Behavioral Health (DPBH) Office of Suicide Prevention. (2021). *Youth Risk Factors*. NV.Gov. <https://suicideprevention.nv.gov/Youth/RiskFactors/>

Novianto, P., Hantoro, M., Budiman, A., Dewi, L., Sita, S. D., Noverdi, H., Ekkuinbang, P. S., Suryani, A. S., Prasetiawan, T., Ade, T., Masyithah, S., Yosephus, A. A., Kesra, M., Trias, Y. I., Febryka, P. K. L., Mohammad, N., Nur, T., Fieka, S. P. S., Koordinator, N. A., ... Suhayati, M. (2024). Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan. *Idntimes.Com*, 1 Oktober, 1–2. <https://pusaka.dpr.go.id>

O'Higgins Norman, J. (2020). Tackling Bullying from the Inside

- Out: Shifting Paradigms in Bullying Research and Interventions: UNESCO Chair on Tackling Bullying in Schools and Cyberspace, Inaugural Lecture delivered on 7th October 2019 at Dublin City University. *International Journal of Bullying Prevention*, 2(3), 161–169. <https://doi.org/10.1007/s42380-020-00076-1>
- Patemah. (2023). Dampak Bunuh Diri. In M. Martini (Ed.), *Bunuh Diri* (pp. 211–226). Media Sains Indonesia.
- Rigby, K. (2020). How teachers deal with cases of bullying at school: What victims say. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph17072338>
- Rizkia, N. D. (2023). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Bunuh Diri. In M. Martini (Ed.), *Bunuh Diri* (p. 13). Media Sains Indonesia.
- Roca-Campos, E., Duque, E., Ríos, O., & Ramis-Salas, M. (2021). The Zero Violence Brave Club: A Successful Intervention to Prevent and Address Bullying in Schools. *Frontiers in Psychiatry*, 12(July), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.601424>
- Sania Mashabi, M. P. (2024). JPPI: Sepanjang Tahun 2024 Ada 293 Kasus Kekerasan di Sekolah "JPPI: Sepanjang Tahun 2024 Ada 293 Kasus Kekerasan di Sekolah. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/163509171/jppi-sepanjang-tahun-2024-ada-293-kasus-kekerasan-di-sekolah>
- Saskia M. Fischer, N. J. & L. B. (2021). Teachers' Self-efficacy in Preventing and Intervening in School Bullying: a

Systematic Review. *International Journal of Bullying Prevention*, 3(1), 196–212.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s42380-020-00079-y>

Tri Damayanty Syamsul; Lala Lala; Kasmawati Karim; Dia rejeki utami;Elvira Safidni. (2024). Hubungan Antara Bullying dengan Kejadian Bunuh Diri Dikalangan Remaja: Kajian Literatur Review. *Journal Omicron Adpertisi*, 3(2).
<https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/joa/article/view/591>

UNICEF. (2017). *Modul Program ROOTS Pencegahan Bullying (Bullying) di Sekolah Menengah Pertama, Panduan untuk Fasilitator*.

Wuryaningsih, Emi Wuri; Windarwati, Heni Dwi; Dewi, Erti Ikhtiarini; Deviantony, Fitrio; Hadi, E. (2018). *Buku Ajar: Keperawatan Kesehatan Jiwa 1*. UNEJ Press.

Xue, J., Hu, R., Chai, L., Han, Z., & Sun, I. Y. (2022). Examining the Prevalence and Risk Factors of School Bullying Perpetration Among Chinese Children and Adolescents. *Frontiers in Psychology*, 13(March), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.720149>

Yanzami, U. M. W. W. (2021). No Title. *Bullying Berhubungan Dengan Risiko Bunuh Diri Pada Remaja*, 13(1).
<https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/1196>

Yosep, Iyus, Rohman Hikmat, Ai Mardhiyah, H. H. andTaty H. (2022). Method of Nursing Interventions to Reduce the Incidence of Bullying and Its Impact on Students in School: A Scoping Review. *Health Care Current*

Reviews, 10(10), 1835.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare10101835>

Yosep, I., Hikmat, R., & Mardhiyah, A. (2023). School-Based Nursing Interventions for Preventing Bullying and Reducing Its Incidence on Students: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2).
<https://doi.org/10.3390/ijerph20021577>

Yosep, I., Purnama, H., Lindayani, L., Chen, Y. C., Sudrajat, D. A., & Firdaus, M. R. (2024). The Relationship Between Bullying and Risk of Suicide Among Adolescents During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35(1), 75–81.
<https://doi.org/10.5765/jkacap.230012>

GLOSARIUM

A

Ask Suicide Screening Questioning: adalah instrumen yang dikembangkan oleh NIMH (National Institute of Mental Health) pada tahun 2008 untuk mendeteksi bunuh diri pada remaja dan dewasa.

Ancaman bunuh diri: adalah ungkapan secara langsung atau tulisan sebagai ekspresi dari niat melakukan bunuh diri namun tanpa adanya tindakan.

B

Bullying: adalah bentuk perilaku agresif tertentu yang dilakukan secara sistematis, terarah, berulang kali dalam jangka waktu yang lama dengan tujuan untuk menyakiti korban yang secara fisik dan sosial lebih lemah dari pelaku.

Bunuh diri: adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya

Bullying Verbal: adalah bentuk bullying yang dilakukan dengan mengejek, menghina, gossip, mencela, menjuluki nama.

Bullying Fisik: adalah bentuk bullying yang dilakukan dengan cara memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, mencakar, menggigit dan meludahi.

Bullying Relasional: adalah bentuk bullying yang dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, mengecualikan, dan penghindaran.

Bullying Elektronik: adalah bentuk bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, *chatting room*, dan lain-lain.

C

Cognitive Behavior Therapy (CBT): adalah terapi yang bertujuan untuk mengubah kognitif atau persepsi klien terhadap masalahnya, dalam rangka melakukan perubahan emosi dan tingkah laku klien.

Columbia Suicide Severity Scale (C-SSRS): adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi bunuh diri yang dikembangkan oleh Posner, et.al (2011) yang diadaptasi dari Formulir sejarah bunuh diri Columbia

E

Evidence-based practice (EBP): adalah proses yang digunakan untuk meninjau, menganalisis, dan menerjemahkan bukti ilmiah terbaru.

I

Ide bunuh diri: adalah pikiran membunuh diri sendiri, baik yang dilaporkan sendiri atau dilaporkan kepada orang lain

Isyarat bunuh diri: adalah tindakan langsung pada diri sendiri tanpa ada luka atau luka kecil dari seseorang yang tidak ada niat untuk mengakhiri hidupnya maupun mengharapkan untuk meninggal pada akhirnya.

K

Konseling: adalah suatu proses bantuan secara profesional antara konselor dan klien

M

***Mental Health First Aid (MHFA)*:** adalah pendekatan pertolongan pertama bunuh diri yang berasal dari Australia.

P

Percobaan bunuh diri: adalah tindakan secara langsung pada diri sendiri dimana terkadang menyebabkan luka kecil atau besar dari seseorang yang berniat untuk menghadapi hidup atau dengan serius mencederai dirinya.

S

***Self-harm Inventory (SHI)*:** adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi bunuh dimana pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat oleh Randy Sansone et al. pada tahun 2011

***Suicidal Intention Rating Scale (SSRI)*:** adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi bunuh diri yang dikembangkan oleh Balley dan Dreyer (1977)

T

***The Scale of Suicide Ideation (SSI)*:** adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi bunuh diri dikembangkan oleh Beck, Kovacs dan Weissman (1979)

PROFIL PENULIS



Yuldensia Avelina, S.Kep., Ns., M.Kep.,

Lahir di Kewapante, 06 Desember 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan Universitas Nusa Nipa pada tahun 2005-2009 selanjutnya melanjutkan studi ke Profesi Ners pada Program Studi Profesi Ners Universitas Nusa Nipa 2009-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya Malang dengan peminatan keperawatan jiwa dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 dan sampai saat ini telah menjadi dosen tetap pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Kesehatan Universitas Nusa Nipa. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial, Keperawatan Psikiatri, Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, dan Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, reviewer artikel jurnal, editor buku nasional, melakukan publikasi, dan seminar. Penulis juga aktif sebagai pengurus organisasi profesi perawat tingkat Kabupaten Sikka (DPD PPNI Sikka).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nersyouully@gmail.com

Motto: "Ora et Labora"

PROFIL PENULIS



Wilhelmus Nong Baba, S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Maumere, 03 Desember 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan Universitas Nusa Nipa pada tahun 2005-2010 selanjutnya melanjutkan studi ke Profesi Ners pada Program Studi Profesi Ners Universitas Nusa Nipa 2011-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2

pada Universitas Indonesia Timur, Makasar pada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 dan sampai saat ini telah menjadi dosen tetap pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Nusa Nipa. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Falsafah Keperawatan, Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, melakukan publikasi, dan seminar. Penulis juga aktif sebagai pengurus organisasi profesi perawat tingkat Kabupaten Sikka (DPD PPNI Sikka).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

wilhelmusnongbaba@gmail.com

Motto: "Sehebat apapun bakat dan talenta seorang penulis, tetapi tidak akan dapat mengalahkan disiplin dan konsistensi"

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang bullying di sekolah dan pengaruhnya terhadap salah satu masalah kesehatan jiwa remaja yakni resiko bunuh diri. Bullying saat ini menjadi fenomena dalam dunia pendidikan yang menjadi perhatian. Selain itu, bullying juga menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memengaruhi kesehatan mental anak dan remaja.

Buku ini memberikan pemahaman kepada pembaca konsep bullying di sekolah dan bunuh diri remaja serta dilengkapi dengan evidence-based practice (EBP) terkait intervensi terhadap bullying di sekolah. Dengan demikian, pembaca dapat mengaplikasi intervensi yang dipaparkan dalam buku ini kepada pelaku, korban, dan saksi dari perilaku bullying.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada mahasiswa keperawatan, para profesional kesehatan, dan masyarakat, dalam upaya bersama untuk menurunkan angka kejadian bullying dan mencegah terjadinya bunuh diri pada remaja.

Buku ini membahas tentang bullying di sekolah dan pengaruhnya terhadap salah satu masalah kesehatan jiwa remaja yakni resiko bunuh diri. Bullying saat ini menjadi fenomena dalam dunia pendidikan yang menjadi perhatian. Selain itu, bullying juga menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memengaruhi kesehatan mental anak dan remaja.

Buku ini memberikan pemahaman kepada pembaca konsep bullying di sekolah dan bunuh diri remaja serta dilengkapi dengan evidence-based practice (EBP) terkait intervensi terhadap bullying di sekolah. Dengan demikian, pembaca dapat mengaplikasi intervensi yang dipaparkan dalam buku ini kepada pelaku, korban, dan saksi dari perilaku bullying.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada mahasiswa keperawatan, para profesional kesehatan, dan masyarakat, dalam upaya bersama untuk menurunkan angka kejadian bullying dan mencegah terjadinya bunuh diri pada remaja.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

